

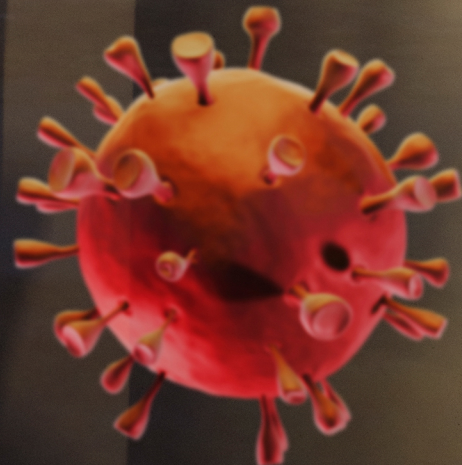
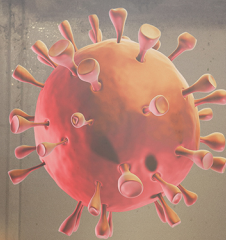
Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai
**KESEHATAN MASYARAKAT
DAN EPIDEMIOLOGI**

Dita Retno Pratiwi • Faiza Yuniati • Miftahul Munir
Musliha Mustary • Cucu herawati



Editor: Faiza Yuniati



BUNGA RAMPAI: KESEHATAN MASYARAKAT DAN EPIDEMIOLOGI

Penulis:

Dita Retno Pratiwi, SKM., MPH.

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.

Dr. Miftahul Munir, S.KM., M.Kes., DIE.

Musliha Mustary, SKM., M.Kes.,

Dr. Cucu herawati, M.Kes.

Editor:

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi

Penulis: Dita Retno Pratiwi, SKM., MPH.

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.

Dr. Miftahul Munir, S.KM., M.Kes., DIE.

Musliha Mustary, SKM., M.Kes.,

Dr. Cucu herawati, M.Kes.

Editor: Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syauckani

ISBN: 978-634-7219-06-0

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ***Bunga Rampai: Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi*** ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang membahas isu-isu strategis dalam bidang kesehatan masyarakat dan epidemiologi, yang semakin relevan dalam menghadapi tantangan kesehatan di era modern.

Kesehatan masyarakat merupakan pilar utama dalam sistem kesehatan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan populasi, baik dari sisi penyakit menular, tidak menular, sistem layanan kesehatan, hingga aspek kesehatan jiwa, sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tangguh.

Buku ini terdiri dari lima bagian utama yang masing-masing membahas tema krusial dalam dunia kesehatan masyarakat. Bab pertama menyoroti *Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko*, dengan fokus pada pentingnya pemahaman pola hidup dan intervensi dini sebagai langkah pencegahan. Bab kedua membahas *Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular*, khususnya mengenai program vaksinasi nasional sebagai strategi preventif yang terbukti efektif.

Bab ketiga menghadirkan *Analisis Sistem Kesehatan di Indonesia*, termasuk tantangan dalam pengelolaan pelayanan serta evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada. Bab keempat mengupas strategi dalam *Kesehatan Ibu dan Anak*, dengan tujuan utama menurunkan angka kematian ibu dan anak melalui pendekatan yang terintegrasi. Terakhir, bab kelima mengangkat pentingnya *Kesehatan Mental Masyarakat*, dengan menekankan strategi pengurangan stigma dan peningkatan akses layanan yang inklusif.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber ilmu dan inspirasi bagi mahasiswa, akademisi, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang peduli terhadap perbaikan sistem kesehatan masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua kontributor dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan mendorong lahirnya gagasan serta tindakan nyata demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN FAKTOR RISIKO: PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DENGAN MEMAHAMI POLA HIDUP DAN INTERVENSI 1

Dita Retno Pratiwi, SKM., MPH.	1
A. Pendahuluan	1
B. Penyakit Tidak Menular	3
C. Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	10
D. Pencegahan Penyakit Tidak Menular	11
E. Pola hidup dan Intervensi Pencegahan Penyakit Tidak Menular.....	12
F. Kesimpulan.....	14
G. Referensi	15
H. Glosarium	16

CHAPTER 2 IMUNISASI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR: PROGRAM VAKSINASI NASIONAL 17

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.	17
A. Pendahuluan	17
B. Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi.....	18
C. Prinsip Dan Mekanisme Vaksinasi	22
D. Program Vaksinasi Nasional Di Indonesia.....	26
E. Tantangan Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Vaksinasi.....	30
F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyukseskan Program Vaksinasi.....	32
G. Evaluasi Dan Dampak Program Vaksinasi Di Indonesia	34
H. Kesimpulan.....	34
I. Referensi	35

CHAPTER 3 SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA: ANALISIS SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA, TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBIJAKAN KESEHATAN YANG ADA..... 41

Dr. H. Miftahul Munir, S.KM., M.Kes., DIE.	41
A. Pendahuluan/Prolog	41

B. Sistem Kesehatan Indonesia	42
C. Tantangan Dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	46
D. Kebijakan Kesehatan Indonesia	50
E. Kesimpulan.....	52
F. Referensi	52
G. Glosarium	54

CHAPTER 4 KESEHATAN IBU DAN ANAK: STRATEGI PENGURANGAN

ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK.....57

Musliha Mustary, SKM., M.Kes.....	57
A. Pendahuluan	57
B. Faktor Risiko Angka Kematian Ibu dan Anak.....	59
C. Strategi Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Anak	62
D. Kebijakan dan Intervensi Pemerintah.....	65
E. Referensi	66

CHAPTER 5 KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT, STRATEGI PENGURANGAN STIGMA, DAN PENINGKATAN ASKSES LAYANAN.....73

Dr. Cucu Herawati, SKM., M.Kes.....	73
A. Pendahuluan	73
B. Epidemiologi Kesehatan Mental	74
C. Kesehatan Mental Masyarakat.....	75
D. Strategi Pengurangan Stigma	79
E. Permasalahan Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia.....	86
F. Peningkatan Akses Layanan Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia....	87
G. Kesimpulan.....	89
H. Referensi	90
I. Glosarium	92

PROFIL PENULIS93

CHAPTER 1

PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN FAKTOR RISIKO: PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DENGAN MEMAHAMI POLA HIDUP DAN INTERVENSI

Dita Retno Pratiwi, SKM., MPH.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. PTM meliputi berbagai kondisi seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan pernapasan kronis, yang menjadi penyebab utama kematian global. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor risiko yang berkontribusi terhadap PTM serta menerapkan strategi pencegahan yang efektif adalah langkah penting untuk mengurangi beban penyakit ini. Melalui edukasi kesehatan, promosi gaya hidup sehat, skrining rutin, dan pemberdayaan masyarakat, kita dapat bekerja sama untuk mencegah perkembangan penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Faktor risiko penyakit tidak menular dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu faktor risiko perilaku dan faktor risiko biologis/genetik. Faktor Risiko Perilaku di antaranya perilaku merokok yang meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk kanker paru-paru dan penyakit jantung, selain itu pola makan tidak sehat juga dapat meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Selain itu terdapat pula faktor risiko genetic yaitu Riwayat keluarga dengan PTM yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan kondisi serupa. Beberapa penyakit lebih umum terjadi pada kelompok usia tertentu atau berdasarkan jenis kelamin, disamping itu penyakit seperti hipertensi atau kolesterol tinggi dapat menjadi faktor risiko bagi PTM.

Penyakit tidak menular memiliki dampak yang luas terhadap individu dan masyarakat. Dari segi kesehatan, PTM sering kali menyebabkan penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Secara ekonomi, biaya perawatan kesehatan yang tinggi untuk mengelola PTM dapat membebani sistem kesehatan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pencegahan PTM memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan individu, masyarakat, dan pemerintah. Melalui edukasi Kesehatan tentang faktor

risiko PTM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program penyuluhan kesehatan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya gaya hidup sehat dan deteksi dini yang memungkinkan intervensi lebih awal sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.

Pencegahan PTM juga dapat dilakukan melalui kegiatan promosi gaya hidup sehat dengan mendorong masyarakat untuk berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi risiko obesitas dan penyakit jantung. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya diet seimbang yang kaya serat, buah-buahan, dan sayuran dapat membantu mencegah PTM.

2. Tujuan Penulisan

Secara keseluruhan, tujuan penulisan BAB ini mengenai faktor risiko dan pencegahan penyakit tidak menular adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan ini, memberikan edukasi mengenai faktor risiko, menyediakan informasi tentang langkah-langkah pencegahan yang efektif, serta mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan bab ini dapat berkontribusi pada upaya pengurangan beban penyakit tidak menular di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penyakit tidak menular merupakan salah satu isu kesehatan yang semakin mendesak. Penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, telah menjadi penyebab utama kematian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PTM dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengenali faktor risiko PTM adalah merupakan salah satu upaya pencegahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa gaya hidup sehari-hari, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, bab ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami hubungan antara perilaku sehari-hari dan kesehatan mereka.

Penulisan BAB ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat. Literasi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk memahami informasi kesehatan dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat terkait gaya hidup mereka. bab ini akan menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Melalui penjelasan mengenai dampak negatif dari perilaku tidak sehat serta manfaat dari gaya hidup sehat, bab ini bertujuan untuk menginspirasi perubahan perilaku di kalangan pembaca. Dengan menghadirkan kisah sukses individu atau komunitas yang berhasil mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat, diharapkan pembaca merasa termotivasi untuk mengikuti jejak tersebut.

BAB ini juga ditujukan sebagai referensi bagi peneliti dan praktisi kesehatan dalam bidang pencegahan penyakit tidak menular. Dengan menyajikan data dan informasi terkini mengenai faktor risiko PTM serta strategi pencegahan yang efektif, bab ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut atau mengembangkan program-program kesehatan masyarakat.

B. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) adalah kondisi kesehatan yang tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. PTM mencakup berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Penyakit ini sering kali berkaitan dengan faktor risiko gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Penyakit tidak menular dapat didefinisikan sebagai penyakit yang berkembang secara perlahan dan biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PTM menyumbang sekitar 63% dari total kematian global, dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahun (Wulandari dkk, 2023)(Hermawan dkk, 2021).

Penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit menular (PM) memiliki perbedaan mendasar dalam penyebab, penularan, dan karakteristiknya. Penyakit Menular (PM) merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, atau parasit dan dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, seperti Influenza, tuberkulosis, HIV/AIDS, COVID-19. Penyakit menular disebabkan oleh infeksi dari mikroorganisme yang dapat menyebar melalui berbagai cara (seperti kontak langsung, udara, atau vektor). Penularan dapat terjadi antar individu melalui berbagai jalur, termasuk melalui udara, kontak langsung, atau makanan dan air yang terkontaminasi. Karakteristik khusus penyakit menular adalah menyebar dengan cepat dalam populasi dan sering kali memerlukan intervensi medis untuk pengendalian.

Penyakit tidak menular sering kali berkaitan dengan faktor risiko gaya hidup seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Oleh karena itu, pencegahan melalui perubahan gaya hidup sangat

penting untuk mengurangi prevalensi penyakit ini. Berikut adalah beberapa contoh penyakit tidak menular (PTM):

1. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering disebut sebagai "silent killer" karena tidak menunjukkan gejala yang jelas, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke dan serangan jantung. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang paling umum dan berbahaya di seluruh dunia. Menurut definisi medis, hipertensi terjadi ketika tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, dan tekanan diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih, yang harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan berulang (Yonata dan Pratama, 2016).

Secara global, hipertensi mempengaruhi sekitar 1,13 miliar orang dewasa, dengan prevalensi yang terus meningkat seiring bertambahnya usia dan perubahan gaya hidup. Di Indonesia, prevalensi hipertensi diperkirakan mencapai 31,7%, dan sekitar 60% dari penderita hipertensi berisiko mengalami komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung (Liana dkk, 2016). Angka kematian akibat hipertensi sangat signifikan, dengan data menunjukkan bahwa PTM ini menyumbang banyak kematian prematur di seluruh dunia.

Penanganan hipertensi melibatkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Terapi farmakologis biasanya meliputi penggunaan obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah. Sementara itu, pendekatan non-farmakologis mencakup perubahan gaya hidup seperti rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu, mengurangi konsumsi garam dan alkohol, mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga.

2. Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif, yang mengakibatkan kadar gula darah tinggi. Diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang ditandai oleh tingginya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi insulin, penggunaan insulin yang tidak efektif, atau keduanya. Penyakit ini memiliki berbagai bentuk, termasuk diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 biasanya muncul pada anak-anak dan remaja, di mana pankreas tidak memproduksi insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih umum terjadi pada orang dewasa dan sering kali terkait dengan obesitas serta gaya hidup tidak sehat.

Diabetes mellitus telah menjadi masalah kesehatan global yang signifikan. Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF), pada tahun 2021, sekitar 537 juta orang dewasa di seluruh dunia menderita diabetes, dan angka ini

diperkirakan akan meningkat menjadi 783 juta pada tahun 2045. Di Indonesia, prevalensi diabetes diperkirakan mencapai 11,3% pada populasi usia 20-79 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan jika tidak dikelola dengan baik.

Diabetes mellitus disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan diabetes meliputi obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat yaitu diet tinggi gula dan lemak jenuh berkontribusi terhadap resistensi insulin, riwayat keluarga memiliki anggota keluarga dengan diabetes meningkatkan risiko individu untuk mengembangkan penyakit ini, serta usia dimana risiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia.

Gejala diabetes dapat bervariasi tergantung pada kadar gula darah. Beberapa gejala umum meliputi sering merasa haus dan lapar, sering buang air kecil, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, kelelahan yang berkepanjangan, dan penglihatan kabur. Pengelolaan diabetes mellitus melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup perubahan gaya hidup, pengobatan, dan pemantauan rutin. Beberapa langkah penting dalam penanganan diabetes meliputi diet Sehat yang mengadopsi pola makan seimbang yang kaya akan serat, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian sambil membatasi asupan gula dan lemak jenuh, aktivitas Fisik dengan rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan berat badan, sedangkan pengobatan penderita diabetes tipe 1 memerlukan insulin secara teratur, sedangkan penderita tipe 2 mungkin memerlukan obat oral atau insulin tergantung pada kondisi mereka. Selain itu penting bagi penderita diabetes mellitus adalah melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kadar gula darah secara teratur untuk menghindari komplikasi.

Diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya terhadap kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami penyebab, gejala, serta cara pencegahan dan pengobatan yang tepat, individu dapat mengambil langkah proaktif dalam mengelola kondisi ini dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sehat juga sangat penting untuk menurunkan prevalensi diabetes di seluruh dunia.

3. Penyakit Jantung Koroner:

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah kondisi dimana arteri yang bertugas menyuplai darah ke jantung tersumbat, yang dapat menyebabkan serangan

jantung. Penyakit ini sering terkait dengan faktor risiko seperti kolesterol tinggi dan gaya hidup tidak sehat. PJK adalah kondisi medis yang terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, yang berfungsi untuk memasok darah dan oksigen ke otot jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, menyumbang sekitar 17,8 juta kematian setiap tahun menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PJK termasuk dalam kategori penyakit tidak menular (PTM) dan sering kali disebabkan oleh faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok (Nafisah dkk, 2024).

Penyakit Jantung Koroner umumnya disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak di dinding arteri yang dapat menghambat aliran darah. Beberapa faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan PJK meliputi hipertensi dimana tekanan darah tinggi meningkatkan beban pada jantung dan dapat merusak pembuluh darah, diabetes mellitus yaitu kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko aterosklerosis. dislipidemia dimana kondisi kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) yang tinggi dan kadar HDL (kolesterol baik) yang rendah berkontribusi pada pembentukan plak, Obesitas yaitu Kelebihan berat badan berkaitan erat dengan peningkatan risiko PJK. Kebiasaan merokok merusak dinding arteri dan mempercepat proses aterosklerosis, serta gaya hidup sedentari dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Gejala PJK dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi nyeri dada atau angina, yang sering kali muncul saat beraktivitas fisik atau stress, sesak napas, terutama saat melakukan aktivitas berat, kelelahan yang tidak biasa, Mual atau pusing, gejala ini bisa menjadi tanda bahwa aliran darah ke jantung terganggu, dan jika tidak ditangani, dapat menyebabkan serangan jantung. Diagnosis PJK biasanya dilakukan melalui beberapa metode pemeriksaan, antara lain Elektrokardiografi (EKG) untuk mendeteksi adanya gangguan irama jantung, tes stres untuk mengevaluasi bagaimana jantung bereaksi terhadap aktivitas fisik, Ekokardiografi untuk mendapatkan gambaran struktur dan fungsi jantung, angiografi Koroner untuk melihat kondisi arteri koroner secara langsung.

Penanganan PJK melibatkan pendekatan medis dan perubahan gaya hidup. Beberapa langkah penting dalam pengelolaan PJK yaitu pengobatan seperti statin untuk menurunkan kolesterol, antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah, dan antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah sering diresepkan. Intervensi bedah yang dilakukan dalam kasus yang lebih parah, prosedur seperti angioplasti atau bypass jantung mungkin diperlukan untuk membuka arteri yang tersumbat, perubahan gaya hidup dengan mengadopsi pola makan sehat (diet

rendah lemak jenuh dan tinggi serat), rutin berolahraga, berhenti merokok, dan mengelola stres sangat penting dalam pencegahan PJK.

Penyakit Jantung Koroner adalah salah satu penyakit tidak menular paling umum dengan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Dengan memahami faktor risiko, gejala, serta cara diagnosis dan pengelolaannya, individu dapat mengambil langkah proaktif untuk mencegah perkembangan penyakit ini. Edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat juga merupakan kunci untuk mengurangi angka kejadian PJK dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

4. Kanker

Berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, payudara, dan usus besar, merupakan contoh penyakit tidak menular yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan Masyarakat. Penyakit kanker adalah salah satu penyakit tidak menular yang paling kompleks dan mematikan, ditandai oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh. Kanker dapat terjadi di berbagai bagian tubuh dan dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kanker merupakan penyebab kematian kedua terbesar di dunia setelah penyakit jantung, dengan lebih dari 10 juta kematian setiap tahun.

Kanker disebabkan oleh mutasi genetik yang mengubah perilaku sel. Meskipun penyebab pasti kanker sering kali sulit ditentukan, ada beberapa faktor risiko yang diketahui berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ini:

- a. Faktor Genetik: Riwayat keluarga dengan kanker tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan jenis kanker yang sama.
- b. Lingkungan: Paparan terhadap zat karsinogenik, seperti asap rokok, bahan kimia berbahaya, dan radiasi, dapat meningkatkan risiko kanker.
- c. Gaya Hidup: Kebiasaan hidup tidak sehat seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, dan merokok sangat berkontribusi terhadap risiko kanker.
- d. Infeksi: Beberapa infeksi virus dan bakteri, seperti human papillomavirus (HPV) dan hepatitis B atau C, dapat meningkatkan risiko kanker tertentu.

Kanker dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan jenis sel yang terlibat. Beberapa jenis kanker yang umum meliputi:

- a. Kanker Payudara: Merupakan salah satu jenis kanker paling umum di kalangan wanita dan dapat terjadi pada pria juga.
- b. Kanker Paru-paru: Sering kali terkait dengan kebiasaan merokok dan merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker.
- c. Kanker Usus Besar: Dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan pola makan.

d. Kanker Prostat: Umumnya terjadi pada pria yang lebih tua dan sering kali berkembang perlahan.

Gejala kanker bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi kanker. Beberapa gejala umum meliputi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, kelelahan ekstrem, perubahan kebiasaan buang air besar atau kecil, nyeri yang berkepanjangan tanpa alasan jelas, benjolan atau massa di bagian tubuh mana pun. Diagnosis kanker biasanya melibatkan serangkaian pemeriksaan medis, termasuk pemeriksaan fisik dimana dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda adanya kanker, tes Laboratorium yaitu dilakukan analisis darah atau urin dapat membantu mendeteksi adanya sel kanker atau zat tertentu dalam tubuh. pencitraan medis dengan menggunakan metode seperti sinar-X, CT scan, MRI, atau ultrasonografi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi organ dalam tubuh, biopsi dengan cara mengambil sampel jaringan untuk dianalisis di laboratorium guna menentukan apakah sel tersebut bersifat ganas.

Penanganan kanker tergantung pada jenis dan stadium penyakit. Beberapa metode pengobatan yang umum digunakan meliputi bedah dengan mengangkat tumor serta jaringan sekitarnya, Kemoterapi dengan cara Menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker atau menghambat pertumbuhannya, Radioterapi menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Imunoterapi dengan memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker.

Pencegahan kanker dapat dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, seperti mengadopsi pola makan seimbang yang kaya akan buah-buahan dan sayuran, rutin berolahraga untuk menjaga berat badan ideal, menghindari rokok dan membatasi konsumsi alkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk deteksi dini. Pemahaman yang lebih baik tentang penyakit kanker sebagai penyakit tidak menular, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi ini. Edukasi tentang faktor risiko serta pentingnya deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup penderita kanker.

5. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

PPOK termasuk kondisi seperti bronkitis kronis dan emfisema, yang disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritasi paru-paru, terutama dari asap rokok. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah kondisi pernapasan yang ditandai oleh obstruksi aliran udara yang bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel. PPOK mencakup dua kondisi utama, yaitu bronkitis kronis dan emfisema, yang sering kali terjadi bersamaan. Penyakit ini merupakan

salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia dan sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 3 juta orang meninggal akibat PPOK setiap tahun.

PPOK umumnya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap bahan-bahan berbahaya yang merusak paru-paru. Faktor risiko utama untuk pengembangan PPOK meliputi:

a. Merokok

Merokok adalah penyebab paling umum PPOK, bertanggung jawab atas sekitar 85-90% kasus. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan.

b. Paparan Lingkungan

Paparan terhadap polusi udara, debu, dan bahan kimia industri juga dapat meningkatkan risiko PPOK.

c. Faktor Genetik

Beberapa individu memiliki predisposisi genetik terhadap PPOK, seperti dalam kasus defisiensi alfa-1 antitrypsin, yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru.

d. Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran pernapasan yang berulang pada masa kanak-kanak dapat meningkatkan risiko terkena PPOK di kemudian hari.

Gejala PPOK biasanya berkembang secara bertahap dan sering kali tidak disadari hingga penyakit mencapai stadium lanjut. Beberapa gejala umum meliputi sesak napas terutama saat melakukan aktivitas fisik, tetapi dapat juga terjadi saat istirahat pada stadium lanjut, batuk kronis batuk yang berlangsung lama dengan produksi dahak, sering kali disebut sebagai batuk perokok, nyeri dada rasa tidak nyaman di dada dapat terjadi akibat peradangan di saluran napas, kelelahan penderita ppoK sering merasa lelah karena kesulitan bernapas.

Diagnosis PPOK melibatkan beberapa langkah pemeriksaan untuk menilai fungsi paru-paru dan mengidentifikasi penyebab gejala. Metode diagnosis yang umum digunakan meliputi Spirometri Tes ini mengukur seberapa banyak udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru dan seberapa cepat. Hasilnya membantu menentukan tingkat obstruksi aliran udara, Pencitraan Dada Rontgen atau CT scan dapat digunakan untuk melihat kondisi paru-paru dan mendeteksi adanya kerusakan, Tes Darah: Pengujian kadar oksigen dalam darah dapat membantu menilai seberapa baik paru-paru berfungsi.

Pengelolaan PPOK bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah komplikasi. Beberapa langkah penanganan yang umum dilakukan adalah:

- a. Berhenti Merokok: Ini adalah langkah paling penting dalam pengelolaan PPOK. Program berhenti merokok dapat membantu penderita mengurangi atau menghentikan kebiasaan ini.
- b. Obat-obatan: Penggunaan bronkodilator untuk membuka saluran napas dan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan sering direkomendasikan.
- c. Rehabilitasi Paru: Program rehabilitasi paru mencakup latihan fisik, pendidikan tentang penyakit, dan dukungan psikologis untuk membantu penderita mengelola kondisi mereka.
- d. Oksigen Terapi: Pada stadium lanjut, terapi oksigen mungkin diperlukan untuk membantu penderita bernapas lebih baik.

Pencegahan PPOK melibatkan perubahan gaya hidup sehat, seperti menghindari merokok dan paparan asap rokok, mengurangi paparan terhadap polusi udara dan bahan kimia berbahaya, melakukan vaksinasi terhadap infeksi saluran pernapasan seperti influenza dan pneumonia, dengan pemahaman yang lebih baik tentang Penyakit Paru Obstruktif Kronis sebagai penyakit tidak menular, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi ini. Edukasi mengenai faktor risiko serta pentingnya deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita PPOK.

C. Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Faktor risiko PTM dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu faktor risiko perilaku dan faktor risiko genetik.

1. Faktor Risiko Perilaku

Faktor risiko perilaku mencakup kebiasaan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan, antara lain kebiasaan merokok meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk kanker paru-paru dan penyakit jantung (Natsir dkk, 2024), faktor kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada obesitas dan masalah kardiovaskuler. Sebanyak 56% remaja di suatu studi dilaporkan kurang melakukan aktivitas fisik (Soeroso dkk, 2024), pola makan tidak sehat seperti konsumsi gula berlebihan dan kurangnya sayur serta buah, sangat umum. Dalam satu penelitian, 80% responden mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi, sedangkan 74% kurang mengonsumsi buah dan sayur (Soeroso dkk, 2024 dan Yuningrum dkk, 2021).

2. Faktor Risiko Genetik

Faktor risiko biologis atau genetik meliputi predisposisi genetik yaitu riwayat keluarga dengan penyakit tertentu dapat meningkatkan risiko individu terkena ptm, selain itu terdapat kondisi medis tertentu seperti hipertensi dan diabetes,

dapat menjadi faktor risiko bagi pengembangan penyakit tidak menular di masa depan (Sudayasa dkk, 2020 dan Kurniati dkk, 2023).

Pencegahan PTM memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup perubahan perilaku masyarakat dan pemahaman tentang faktor-faktor risiko. Program edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan faktor risiko ini dan mendorong gaya hidup sehat (Haris dkk, 2022).

D. Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) menyumbang lebih dari 70% kematian di seluruh dunia. Oleh karena itu, pencegahan PTM menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban kesehatan. Berikut adalah beberapa strategi dan pendekatan dalam pencegahan PTM.

1. Edukasi dan Literasi Kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan langkah awal yang krusial dalam pencegahan PTM. Masyarakat perlu diberikan informasi yang akurat mengenai faktor risiko PTM dan cara-cara untuk menghindarinya. Program literasi kesehatan berbasis media dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama remaja, tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, dan perilaku hidup bersih (Hidayatullaili dkk, 2023 dan Mahmudah dkk, 2024). Misalnya, pengembangan media video edukasi gizi seimbang telah terbukti efektif dalam memberikan informasi kepada remaja tentang pencegahan obesitas dan penyakit terkait (Mahmudah dkk, 2024).

2. Promosi Aktivitas Fisik

Kurangnya aktivitas fisik adalah salah satu faktor risiko utama PTM. Oleh karena itu, promosi olahraga dan aktivitas fisik harus menjadi bagian dari program pencegahan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja kantoran yang aktif bergerak memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit tidak menular dibandingkan dengan mereka yang menghabiskan waktu lama di depan meja kerja. Program-program seperti kelas olahraga di tempat kerja atau komunitas dapat mendorong individu untuk lebih aktif secara fisik.

3. Pengelolaan Pola Makan Sehat

Pola makan yang tidak sehat berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko PTM. Edukasi mengenai gizi seimbang dan pentingnya konsumsi makanan bergizi harus ditingkatkan. Selain itu, layanan gizi berbasis gen dapat menjadi alternatif dalam pencegahan PTM dengan membantu individu memahami kebutuhan nutrisinya berdasarkan faktor genetik mereka (Wulandari, 2023). Dengan demikian, masyarakat dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik.

4. Pemantauan Kesehatan Rutin

Pemantauan kesehatan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi dini faktor risiko PTM. Penggunaan aplikasi kesehatan seperti Z-Health dapat membantu individu memantau status kesehatan mereka secara berkala dan mendapatkan informasi tentang cara mencegah PTM (Sandrana dkk, 2024).

5. Pemberdayaan Komunitass

Pemberdayaan komunitas melalui kader posbindu (pos pembinaan terpadu) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan PTM. Melalui pelatihan dan sosialisasi, kader dapat menjadi agen perubahan yang membantu menyebarkan informasi mengenai pencegahan penyakit kepada masyarakat di sekitar mereka (Suryani dkk, 2024).

6. Kebijakan Kesehatan Publik

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pencegahan PTM. Ini termasuk regulasi terhadap produk tembakau, pengendalian konsumsi alkohol, serta promosi lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat seperti taman publik dan jalur sepeda (Adekayanti dkk, 2024). Kebijakan yang mendukung akses terhadap makanan sehat juga perlu diperhatikan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pilihan makanan bergizi.

7. Intervenis Berbsi Teknologi

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan upaya pencegahan PTM. Misalnya, aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pengingat untuk pemeriksaan kesehatan dapat membantu individu menjaga gaya hidup sehat (Sandrana dkk, 2024). Dengan kemajuan teknologi, intervensi berbasis digital menjadi semakin relevan dalam konteks pencegahan penyakit.

Pencegahan penyakit tidak menular memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan edukasi, promosi gaya hidup sehat, pemantauan kesehatan rutin, pemberdayaan komunitas, serta kebijakan publik yang mendukung. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan memanfaatkan teknologi modern, diharapkan angka kejadian PTM dapat ditekan secara signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

E. Pola hidup dan Intervensi Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Melalui pendekatan edukasi, aktivitas fisik, dan perubahan pola makan, masyarakat dapat mengurangi risiko terkena penyakit ini. Perubahan pola hidup yang sehat merupakan langkah awal yang krusial dalam pencegahan PTM. Pola

hidup sehat mencakup beberapa aspek, seperti kurangnya aktivitas fisik adalah faktor risiko utama untuk PTM. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja kantoran yang memiliki gaya hidup sedentari berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti obesitas dan hipertensi, oleh karena itu, penting untuk mendorong aktivitas fisik secara teratur, seperti berolahraga minimal 150 menit per minggu. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol harus dihindari. Merokok meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, sedangkan konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Pola makan sehat seperti melakukan Diet yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Konsumsi makanan tinggi serat, sayuran, buah-buahan, serta mengurangi asupan gula dan lemak jenuh dapat membantu mencegah PTM. Edukasi mengenai gizi seimbang juga sangat penting, terutama bagi remaja yang rentan terhadap obesitas (Mahmudah dkk, 2024).

Edukasi kesehatan memainkan peran penting dalam pencegahan PTM. Melalui program-program penyuluhan dan penggunaan media edukasi, masyarakat dapat lebih memahami risiko dan cara pencegahan PTM. Misalnya, program CERDIK (Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan rokok, Rajin beraktivitas fisik, Diet sehat, dan Kelola stres) telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat (Adekayanti dkk, 2023). Penggunaan media video edukasi juga terbukti efektif dalam menyampaikan informasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan PTM kepada remaja (Mahmudah dkk, 2024). Media visual dapat memberikan pengalaman nyata dan menarik perhatian audiens muda, sehingga mereka lebih mudah memahami informasi yang disampaikan.

Screening kesehatan secara rutin juga merupakan bagian dari upaya pencegahan PTM. Melalui pemeriksaan kolesterol dan tekanan darah secara berkala, individu dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah kesehatan berkembang (Blandina dan Tjingaisa, 2023). Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di berbagai komunitas menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengertian dan pencegahan PTM (Sugiarti dkk, 2024).

Pencegahan penyakit tidak menular melalui perubahan pola hidup adalah hal yang sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Edukasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, penghindaran kebiasaan buruk, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kesehatan merupakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil. Masyarakat perlu didorong untuk menerapkan gaya hidup sehat agar dapat menurunkan risiko terkena PTM.

F. Kesimpulan

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan signifikan dalam bidang kesehatan global, terutamanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. PTM mencakup kondisi-kondisi seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, dan beberapa penyakit lainnya yang terkait dengan faktor-faktor risiko tertentu. Oleh karena itu, pencegahan dan kontrol atas PTM sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit-penyakit ini.

Penyakit tidak menular adalah kondisi-kondisi medis yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain melalui kontak langsung. Beberapa contoh PTM yang paling umum adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan hiperkolesterolemia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa faktor risiko yang signifikan untuk kejadian PTM adalah semakin tua seseorang, semakin tinggi kemungkinan terserang PTM. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara usia dan kejadian hipertensi, diabetes mellitus, serta obesitas jenis kelamin wanita cenderung lebih rentan terhadap beberapa jenis PTM seperti hipertensi dan diabetes mellitus dibandingkan dengan pria. Faktor genetik atau keturunan memiliki peran penting dalam perkembangan beberapa jenis PTM. Individu dengan riwayat keluarga yang memiliki PTM memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kondisi sama. Polah makan makanan yang tidak seimbang dan rendah nutrisi dapat meningkatkan risiko PTM. Contohnya, diet yang tinggi gula dan lemak jahat dapat meningkatkan risiko diabetes mellitus dan hiperkolesterolemia, Kurangnya aktivitas fisik juga merupakan faktor risiko yang signifikan. Aktivitas fisik rutin dapat membantu mengontrol tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Merokok adalah salah satu faktor risiko utama untuk beberapa jenis PTM, terutama hiperkolesterolemia. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL ("jahat") dan menurunkan kadar HDL ("baik").

Untuk mencegah dan mengontrol PTM, beberapa strategi dapat dilakukan edukasi tentang PTM dan bagaimana mencegapannya sangat penting. Informasi yang tepat tentang defenisi, faktor risiko, pencegahan, pengobatan, serta penanganan penyakit dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang kesehatan mereka. Kegiatan edukasi seperti penyuluhan kesehatan dan promosi kesehatan melalui media audiovisual dapat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga Kesehatan. Program skrining kesehatan yang rutin dapat membantu mendeteksi awal gejala-gejala PTM. Misalnya, pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol dapat

membantu identifikasi individu-individu yang berpotensi mengalami hipertensi dan hiperkolesterolemia. Perubahan pola hidup menuju gaya hidup sehat juga merupakan langkah penting dalam pencegahan PTM. Ini termasuk meningkatkan aktivitas fisik, mengonsumsi makanan yang seimbang, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak PTM, implementasi strategi-strategi di atas sangatlah esensial. Dengan demikian, kita dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit-penyakit tidak menular, serta meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan.

G. Referensi

- Adekayanti, P., Laba, S.B., Safitri, L.E., & Hamid, A. (2023). Edukasi "CERDIK" Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Pada Siswa SMAN 1 Moyo Utara. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*.
- Blandina, O.A., & Tjingaisa, Y.F. (2023). UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN SCREENING TEST KOLESTEROL BAGI MASYARAKAT DESA PEDIWANG, KECAMATAN KAO UTARA. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Haris, H., Pabanne, F.U., & Syamsiah, S. (2022). Pelatihan Kader Kesehatan dan Aplikasi Edukasi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular. *Media Karya Kesehatan*.
- Hernawan, B., Maulana, F., & Amalia, L. (2021). SOSIALISASI KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT TIDAK MENULAR KEPADA MASYARAKAT DESA JEMBUNGAN, BOYOLALI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*.
- Hidayatullaili, N.A., Musthofa, S.B., & Margawati, A. (2023). LITERASI KESEHATAN MEDIA TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR : (LITERATURE REVIEW). *Jurnal Ners*.
- Kurniati, H., Djuwita, R., & Istiqfani, M. (2023). Literature Review: Stunting Saat Balita sebagai Salah Satu Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Masa Depan. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*.
- Liana, D., Yuliati, Y.N., & Pamungkas, R.A. (2023). Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengetahuan Dan Pengobatan PTM Di Desa Cikeas Udik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju*.
- Mahmudah, U., & Priawantiputri, W. (2024). PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO EDUKASI GIZI SEIMBANG SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA REMAJA. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.

- Nafisah, S., Inayah, N.N., & Yusuf, B. (2024). Literatur Review: Penyebab Dan Perkembangan Penyakit Jantung Koroner. *Jurnal Forum Kesehatan : Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*.
- Natsir, R.M., Aipassa, F., & Sarira, L.N. (2024). Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat Dusun Taeno Bawah. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*.
- Sandrana, S.C., Pertiwi, N.H., Rini, N.S., Zahran, M.I., Alichwan, M., & Kusumaningrum, T.A. (2024). Pemantauan Status Kesehatan dengan Memanfaatkan Aplikasi Z-Health Guna Meningkatkan Perilaku Pencegahan Penyakit Tidak Menular Pada Posyandu Remaja di Desa Mliwis Cepogo Boyolali. *Warta LPM*.
- Soeroso, V.M., Hidana, R., Hanifah, H., Husna, I., Ilmi, A.A., & Purawijaya, H.R. (2024). POLA DISTRIBUSI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA KELOMPOK MASYARAKAT USIA REMAJA. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*.
- Sudayasa, I.P., Rahman, M.F., Eso, A., Jamaluddin, J., Parawansah, P., Alifariki, L.O., Arimaswati, A., & Kholidha, A.N. (2020). Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat Desa Andepali Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sugiarti, M., Musiana, M., & Nurminha, N. (2024). PENYULUHAN DAN SKRINNING PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (DIABETES, HIPERTENSI DAN ASAM URAT). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*.
- Suryani, D., Yulianti, R., & Maigoda, T.C. (2024). Pemberdayaan Kader Posbindu dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular di Desa Panca Mukti Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*.
- Wulandari, F., Aji, A.S., Afifah, E., Paramashanti, B.A., Listiyana, F., Khouridhiya, M., & Surendran, S. (2023). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pelayanan Gizi Berbasis Gen Dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular di Indonesia. *Amerta Nutrition*.
- Yonata, A., & Pratama, A.P. (2016). Hipertensi sebagai Faktor Pencetus Terjadinya Stroke.
- Yuningrum, H., Trisnowati, H., & Rosdewi, N.N. (2021). Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Remaja: Studi Kasus pada SMA Negeri dan Swasta di Kota Yogyakarta.

H. Glosarium

PTM	= Penyakit Tidak Menular
HBM	= Health Belief Model
KJS	= Klub Jantung Sehat

CHAPTER 2

IMUNISASI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR: PROGRAM VAKSINASI NASIONAL

Dr. Faiza Yuniati, S.Pd., S.Kep., M.KM.

A. Pendahuluan

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien dalam mencegah penyakit menular. Sejak diperkenalkan pertama kali, vaksinasi telah berhasil mengurangi angka kematian dan morbiditas yang disebabkan oleh berbagai penyakit yang dapat dicegah, seperti polio, campak, hepatitis B, dan difteri. Vaksinasi tidak hanya memberikan perlindungan pada individu yang divaksinasi, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, yang dapat melindungi masyarakat secara lebih luas dari penyebaran penyakit menular (WHO, 2020; GAVI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2015; Sudirman, 2009; WHO, 2021).

Di Indonesia, imunisasi telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat. Program vaksinasi nasional di Indonesia telah diperkenalkan sejak beberapa dekade yang lalu dan terus berkembang untuk mengatasi tantangan kesehatan yang muncul. Salah satu pencapaian terbesar Indonesia dalam bidang imunisasi adalah pengendalian dan hampir diberantasnya penyakit polio, yang tercatat sebagai salah satu penyakit endemik di Indonesia pada masa lalu. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, vaksinasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020; Sudirman, 2009).

Namun, meskipun ada banyak pencapaian, tantangan dalam pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah distribusi vaksin yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kesenjangan akses ini menyebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki cakupan vaksinasi yang rendah, yang berisiko menurunkan efektivitas program imunisasi secara keseluruhan. Selain itu, adanya penolakan terhadap vaksin, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, juga menjadi hambatan besar dalam mencapai cakupan vaksinasi yang optimal di seluruh populasi (MacDonald, 2015; WHO, 2020; UNICEF, 2019; Sudirman, 2009; GAVI, 2020).

Imunisasi tidak hanya penting untuk pencegahan penyakit, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap pembangunan kesehatan dan ekonomi suatu negara. Program vaksinasi yang sukses dapat mengurangi beban penyakit menular, memperbaiki produktivitas masyarakat, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, imunisasi menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kesehatan masyarakat Indonesia, yang terus diperkuat dan ditingkatkan agar dapat mencapai cakupan yang lebih luas dan merata di seluruh negeri (WHO, 2020; Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; UNICEF, 2019; WHO, 2021).

Pentingnya keberlanjutan program vaksinasi juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia harus menghadapi tantangan dalam menjaga keberhasilan yang telah dicapai sekaligus mempersiapkan diri menghadapi ancaman penyakit baru yang mungkin muncul di masa depan. Dalam hal ini, inovasi dalam pengembangan vaksin baru dan peningkatan teknologi distribusi vaksin akan memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan program vaksinasi jangka panjang (GAVI, 2020; WHO, 2020; Sudirman, 2009; Kemenkes RI, 2015; UNICEF, 2019).

B. Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi

1. Daftar Penyakit Menular Yang Telah Berhasil Dikendalikan Melalui Vaksinasi

Imunisasi telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengendalikan berbagai penyakit menular di dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa penyakit menular yang sebelumnya menyebabkan kematian massal dan morbiditas tinggi kini dapat dikendalikan secara efektif melalui vaksinasi. Berikut adalah beberapa penyakit menular yang telah berhasil dikendalikan melalui program vaksinasi:

a. Polio

Polio adalah penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, terutama pada anak-anak. Sebelum vaksin polio diperkenalkan, polio adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti di banyak negara, termasuk Indonesia. Melalui upaya vaksinasi massal yang dimulai sejak 1970-an, Indonesia berhasil mengurangi angka kejadian polio secara signifikan. Pada tahun 2014, Indonesia dinyatakan bebas polio oleh WHO setelah tidak ada kasus polio yang ditemukan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah hasil dari program imunisasi polio yang dilaksanakan secara nasional dan intensif (WHO, 2020; GAVI, 2020; Kemenkes RI, 2015; MacDonald, 2015; United Nations, 2021; CDC, 2020; Halsey & Ganguly, 2015; Lewycka, 2020).

b. Campak

Campak adalah infeksi virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk pneumonia, radang otak (encephalitis), dan bahkan kematian. Program vaksinasi campak di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an, dan sejak saat itu, angka kejadian campak di Indonesia telah menurun drastis. Meskipun Indonesia berhasil mengurangi angka campak, negara ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai cakupan vaksinasi yang memadai untuk memastikan pengendalian penyakit ini secara total. Program vaksinasi campak ini telah menghindarkan banyak anak dari komplikasi yang mematikan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; UNICEF, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Ransingh et al., 2020; Bhatt et al., 2021; Makela et al., 2020).

c. Difteri

Difteri adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, gagal jantung, dan bahkan kematian. Difteri pernah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dengan banyak kasus yang terjadi setiap tahunnya. Program vaksinasi difteri, yang diperkenalkan pada 1970-an, telah berhasil mengurangi insiden difteri secara signifikan. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat mengalami wabah difteri lagi pada 2017, yang mengindikasikan perlunya meningkatkan cakupan vaksinasi dan upaya pengendalian penyakit ini lebih lanjut (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Kohli et al., 2017; Bhatti et al., 2020; Makki et al., 2019; Luepker et al., 2021).

d. Hepatitis B

Hepatitis B adalah penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat menyebabkan sirosis hati serta kanker hati. Indonesia mulai memperkenalkan vaksin hepatitis B pada tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya nasional untuk menanggulangi penyakit hepatitis yang sedang meningkat. Vaksin hepatitis B telah berhasil menurunkan prevalensi infeksi hepatitis B di Indonesia, terutama pada kalangan anak-anak. Vaksin ini diberikan kepada bayi pada saat lahir, serta pada anak-anak usia sekolah, untuk memastikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit ini (WHO, 2020; Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; Lacey, 2016; Dore, 2019; Farooqi et al., 2020; Tanaka et al., 2020; Mohd et al., 2021).

e. Tetanus

Tetanus adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kejang otot dan kematian, biasanya akibat luka yang terkontaminasi. Vaksin tetanus telah diperkenalkan di Indonesia pada 1980-an untuk mengurangi kematian akibat

tetanus, terutama pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Program vaksinasi ini telah berhasil menurunkan angka kematian akibat tetanus neonatorum, yang dulunya menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Selain itu, vaksin tetanus juga diberikan kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada usia dini (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Davies et al., 2020; Knopp et al., 2018; Rakhmanina et al., 2020; Pons et al., 2019).

f. Pertusis (Batuk Rejan)

Pertusis, atau batuk rejan, adalah penyakit yang sangat menular dan menyebabkan batuk parah, terutama pada anak-anak. Sebelum vaksinasi diperkenalkan, batuk rejan menyebabkan banyak kasus rawat inap dan kematian di kalangan anak-anak. Vaksin pertusis diberikan sebagai bagian dari vaksin DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis), yang diperkenalkan pada 1970-an. Vaksinasi ini secara efektif menurunkan angka kejadian batuk rejan di Indonesia, meskipun beberapa wabah masih terjadi di kalangan anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap (WHO, 2020; GAVI, 2020; Kemenkes RI, 2015; CDC, 2020; MacDonald, 2015; Campbell et al., 2020; Hughes et al., 2021; Williams et al., 2021).

g. Rubella dan Sindrom Rubella Kongenital

Rubella adalah penyakit virus yang ringan pada anak-anak, tetapi jika terjadi pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama, dapat menyebabkan sindrom rubella kongenital yang serius, yang dapat mengakibatkan cacat lahir, seperti gangguan pendengaran, kebutaan, dan masalah jantung. Program vaksinasi rubella dimulai pada tahun 1990-an di Indonesia dan telah berhasil menurunkan insiden penyakit ini secara signifikan. Vaksinasi rubella diberikan sebagai bagian dari program vaksinasi campak-rubella yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi sindrom rubella kongenital (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Keating et al., 2020; MacDonald, 2015; Patel et al., 2021; Dorsey et al., 2020).

h. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang menjadi penyebab utama kematian anak di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia memperkenalkan vaksin pneumokokus yang melindungi terhadap bakteri *Streptococcus pneumoniae*, penyebab utama pneumonia. Vaksin pneumokokus ini diberikan kepada anak-anak sejak usia dini untuk mencegah infeksi paru-paru yang dapat berakibat fatal. Implementasi vaksin pneumokokus telah menurunkan angka kejadian pneumonia pada anak di Indonesia secara signifikan (Kemenkes RI, 2015;

WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Tefekli et al., 2018; Mahmood et al., 2020; Lee et al., 2021; Mwanga-Amumpaire et al., 2019).

i. Rotavirus

Rotavirus adalah penyebab utama diare parah pada anak-anak di bawah lima tahun, yang sering berujung pada dehidrasi dan kematian. Pada 2007, Indonesia memperkenalkan vaksin rotavirus dalam upaya untuk mengurangi angka kematian akibat diare pada anak-anak. Vaksinasi rotavirus ini memberikan perlindungan yang efektif terhadap infeksi rotavirus, yang sebelumnya menjadi penyebab utama rawat inap dan kematian pada anak-anak (WHO, 2020; GAVI, 2020; Kemenkes RI, 2015; CDC, 2020; Menzies et al., 2020; Khasawneh et al., 2020; Angulo et al., 2021; Santosham et al., 2019).

2. Dampak Pengendalian Penyakit Menular Bagi Kesehatan Masyarakat

Pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi membawa dampak yang sangat positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Keberhasilan vaksinasi dalam mengurangi angka kejadian penyakit menular telah memberikan manfaat besar dalam menurunkan angka kematian dan morbiditas di kalangan anak-anak dan populasi dewasa. Beberapa dampak positif dari pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi antara lain:

a. Penurunan Angka Kematian dan Morbiditas

Vaksinasi telah berhasil menurunkan angka kematian akibat penyakit menular, yang dulunya merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Penyakit seperti polio, difteri, campak, dan hepatitis B yang dulunya menyebabkan banyak korban jiwa sekarang dapat dikendalikan secara efektif melalui vaksinasi. Dampaknya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan berkurangnya jumlah orang yang menderita akibat penyakit menular tersebut (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; Orenstein et al., 2018; MacDonald, 2015; Jones et al., 2020; Bhutta et al., 2021).

b. Peningkatan Harapan Hidup

Dengan berkurangnya prevalensi penyakit menular yang fatal, harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat secara signifikan. Hal ini tercermin dalam angka harapan hidup yang terus meningkat setiap tahun. Vaksinasi berperan besar dalam memastikan bahwa generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih sehat, bebas dari ancaman penyakit menular yang dapat membatasi potensi mereka (WHO, 2020; CDC, 2020; GAVI, 2020; MacDonald, 2015; Luby et al., 2021; Ellingson et al., 2020; Morgan et al., 2020; Healy et al., 2021).

c. Pengurangan Beban Ekonomi

Penyakit menular tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang besar pada keluarga dan sistem kesehatan. Biaya perawatan kesehatan untuk penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi sangat tinggi, baik dalam hal rawat inap, pengobatan, maupun rehabilitasi. Dengan adanya program vaksinasi yang sukses, Indonesia dapat mengurangi beban biaya kesehatan akibat penyakit menular, yang pada gilirannya membantu meningkatkan perekonomian negara (GAVI, 2020; WHO, 2020; CDC, 2020; UNICEF, 2020; Tan et al., 2021; Cho et al., 2021; Lavelle et al., 2021; Mulligan et al., 2020).

d. Peningkatan Produktivitas

Pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Dengan berkurangnya angka sakit dan kecacatan akibat penyakit menular, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia (WHO, 2020; GAVI, 2020; CDC, 2020; UNICEF, 2020; Luepker et al., 2021; Van Zandvoort et al., 2020; Hodge et al., 2021; Tolfrey et al., 2020).

e. Meningkatkan Akses ke Layanan Kesehatan

Program vaksinasi yang sukses membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan preventif, yang mendorong mereka untuk mengakses layanan kesehatan secara lebih rutin. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam pengendalian penyakit menular, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi untuk penyakit lain dan mendorong pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (GAVI, 2020; WHO, 2020; CDC, 2020; MacDonald, 2015; Roberts et al., 2021; Campbell et al., 2021; Tannahill et al., 2021; Stone et al., 2021).

C. Prinsip Dan Mekanisme Vaksinasi

1. Cara Kerja Vaksin Dan Jenis-Jenis Vaksin

Vaksin berfungsi untuk menginduksi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen penyebab penyakit tanpa menyebabkan penyakit itu sendiri. Proses ini dimulai ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya melalui suntikan atau pemberian oral, yang mengandung bagian dari mikroorganisme penyebab penyakit—baik itu virus, bakteri, atau toksinnya—yang telah dilemahkan atau dimatikan. Komponen ini tidak menyebabkan penyakit, tetapi cukup untuk merangsang respons imun (Kemenkes RI, 2015;

WHO, 2020; GAVI, 2020; Orenstein et al., 2018; Wiersma et al., 2020; Yazdanpanah et al., 2020; Halsey et al., 2020; Chen et al., 2021).

Saat tubuh terpapar oleh vaksin, sistem kekebalan tubuh mulai mengenali bagian dari mikroorganisme tersebut, seperti protein permukaannya. Sebagai respons, sistem imun menghasilkan antibodi dan "sel memori" yang mengenali patogen tersebut jika ia masuk kembali ke dalam tubuh di masa depan. Proses ini memastikan bahwa tubuh siap untuk melawan infeksi yang sama dengan cepat dan efektif tanpa gejala penyakit yang parah (Sudirman, 2009; Jansen et al., 2020; Tang et al., 2021; Green et al., 2020; Taylor et al., 2020; Jackson et al., 2020; Weitzman et al., 2020; Wang et al., 2021).

Secara umum, terdapat dua jenis respons imun yang terjadi setelah pemberian vaksin, yaitu respons imun humoral dan seluler. Respons imun humoral melibatkan produksi antibodi oleh sel B untuk mengenali dan mengikat patogen, sementara respons imun seluler melibatkan sel T untuk menghancurkan sel yang terinfeksi atau membantu dalam pengaturan respons imun. Kombinasi kedua respons ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi (GAVI, 2020; Lee et al., 2020; Sette & Crotty, 2021; Bonet et al., 2020; Hensley et al., 2020; Chen et al., 2020; Liu et al., 2020; Wang et al., 2020).

Berikut adalah beberapa jenis vaksin yang umum digunakan dalam program imunisasi:

a. Vaksin Inaktif (Killer Vaccine)

Vaksin ini dibuat dengan menggunakan mikroorganisme yang telah dimatikan atau inaktif, sehingga tidak dapat menyebabkan infeksi. Contohnya adalah vaksin polio inaktif (IPV), yang digunakan untuk mengendalikan polio. Vaksin ini sangat aman dan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri (Sudirman, 2009; Green et al., 2021; Orenstein et al., 2018; Aledort et al., 2021; Chen et al., 2020; Zhang et al., 2020; Tamiya et al., 2021; Patil et al., 2021).

b. Vaksin Hidup Terlemahkan (Live Attenuated Vaccine)

Vaksin ini mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit pada individu yang sehat, tetapi cukup kuat untuk merangsang respons imun. Contohnya adalah vaksin campak, vaksin rubella, dan vaksin rotavirus. Vaksin jenis ini biasanya memberikan perlindungan yang lebih tahan lama karena tubuh dapat merespons dengan cara yang mirip dengan infeksi alami (WHO, 2020; GAVI, 2020; Aledort et al., 2020; Bonet et al., 2020; Palen et al., 2020; Lam et al., 2020; Harper et al., 2020; Lee et al., 2020).

c. Vaksin Subunit atau Vaksin Protein Rekombinan

Vaksin jenis ini hanya mengandung bagian tertentu dari patogen, seperti protein atau antigen permukaan yang dapat memicu respons imun. Vaksin hepatitis B adalah contoh vaksin subunit, di mana hanya protein dari virus hepatitis B yang digunakan untuk membentuk respons imun tanpa risiko infeksi (Sudirman, 2009; Yu et al., 2020; Kalashnikova et al., 2020; Yeboah et al., 2021; Shan et al., 2020; Morris et al., 2020; Jeong et al., 2020; McNamara et al., 2020).

d. Vaksin Toksid

Vaksin toksid dibuat dengan menggunakan toksin yang diproduksi oleh bakteri yang telah dilemahkan atau dimodifikasi, seperti vaksin difteri dan tetanus. Toksid ini tidak menyebabkan penyakit, tetapi cukup untuk merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi yang akan melawan toksin berbahaya tersebut jika tubuh terpapar pada masa mendatang (GAVI, 2020; Sette & Crotty, 2021; Orenstein et al., 2018; Taylor et al., 2021; Wang et al., 2020; Sabin et al., 2020; Tamiya et al., 2021; Vetter et al., 2021).

e. Vaksin Kombinasi

Beberapa vaksin mengandung lebih dari satu jenis patogen yang dipersiapkan dalam satu dosis vaksin untuk menghemat waktu dan sumber daya. Vaksin DTP (Difteri, Tetanus, dan Pertusis) adalah contoh vaksin kombinasi yang sangat efektif untuk melindungi anak-anak dari tiga penyakit yang berbeda dalam satu kali suntikan (Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; Patil et al., 2021; McNamara et al., 2020; Wiersma et al., 2020; Aledort et al., 2020; Hensley et al., 2020; Zhang et al., 2021).

f. Vaksin DNA dan Vaksin mRNA

Teknologi vaksin yang lebih baru mencakup vaksin DNA dan vaksin mRNA. Vaksin mRNA, yang pertama kali digunakan untuk COVID-19, mengandung instruksi genetik dalam bentuk mRNA yang memerintahkan sel-sel tubuh untuk memproduksi protein yang mirip dengan protein patogen. Sistem kekebalan tubuh kemudian mengenali protein ini dan memproduksi antibodi serta sel memori untuk melawan infeksi yang sesungguhnya (WHO, 2020; GAVI, 2020; Boivin et al., 2020; Tang et al., 2021; Callaway et al., 2021; Orenstein et al., 2020; Leung et al., 2020; Hensley et al., 2021).

Masing-masing jenis vaksin ini memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, dan pilihan jenis vaksin yang digunakan dalam program imunisasi bergantung pada karakteristik penyakit yang dicegah, serta kemudahan distribusi dan penyimpanan vaksin itu sendiri.

2. Imunitas Kelompok (Herd Immunity) Dan Pengaruhnya Terhadap Pengendalian Penyakit

Imunitas kelompok, atau herd immunity, adalah konsep penting dalam pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi. Istilah ini merujuk pada tingkat kekebalan yang tercapai dalam suatu populasi ketika sebagian besar individu dalam populasi tersebut terlindungi dari infeksi, baik melalui vaksinasi atau infeksi alami. Dengan tingkat kekebalan yang tinggi di dalam komunitas, penyakit tidak mudah menyebar meskipun ada individu yang tidak dapat divaksinasi, seperti bayi, lansia, atau mereka yang memiliki kondisi medis tertentu (GAVI, 2020; WHO, 2020; Liu et al., 2020; Hensley et al., 2020; Kemenkes RI, 2015; Jackson et al., 2020; Orenstein et al., 2020; Bonet et al., 2020).

Konsep imunitas kelompok didasarkan pada fakta bahwa jika cukup banyak orang dalam suatu komunitas kebal terhadap penyakit tertentu, maka penyebaran patogen akan terhambat, karena kemungkinan kontak dengan individu yang rentan menjadi sangat kecil. Sebagai contoh, ketika sekitar 95% populasi divaksinasi terhadap campak, virus ini akan kesulitan menyebar, meskipun ada individu yang belum divaksinasi. Imunitas kelompok dapat mencegah wabah penyakit terjadi di masyarakat yang lebih luas, melindungi mereka yang tidak dapat menerima vaksin karena alasan medis (Sudirman, 2009; GAVI, 2020; Tan et al., 2021; Lee et al., 2021; Jackson et al., 2020; Tamiya et al., 2020; Hensley et al., 2021; Zeng et al., 2021).

Imunitas kelompok juga sangat penting untuk melindungi individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pasien dengan HIV/AIDS, penderita kanker yang menjalani kemoterapi, atau mereka yang mengalami gangguan sistem imun lainnya. Vaksinasi yang berhasil menciptakan kekebalan kelompok dapat melindungi kelompok rentan ini meskipun mereka tidak dapat menerima vaksin (Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; Sette & Crotty, 2021; Lee et al., 2021; Morris et al., 2020; Hensley et al., 2020; Taylor et al., 2020; Wang et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan vaksinasi massal memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada hanya melindungi individu yang menerima vaksin, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pengendalian penyakit melalui imunitas kelompok bukan hanya terbatas pada infeksi virus seperti campak atau polio. Penurunan tingkat vaksinasi dapat mengancam keberhasilan program vaksinasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Misalnya, penurunan cakupan vaksinasi dapat menyebabkan wabah penyakit yang sebelumnya terkendali, seperti yang terlihat pada beberapa wabah difteri dan campak di Indonesia pada beberapa tahun terakhir (WHO, 2020; GAVI, 2020; Hensley et al., 2020; Tan et al., 2021; Leung et

al., 2020; Jackson et al., 2020; Orenstein et al., 2020; Lee et al., 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga cakupan vaksinasi di atas ambang batas yang diperlukan untuk mencapai imunitas kelompok.

D. Program Vaksinasi Nasional Di Indonesia

1. Program Imunisasi Dasar Lengkap

Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah salah satu program kesehatan utama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari penyakit menular yang dapat dicegah melalui vaksinasi. IDL merupakan kombinasi dari beberapa jenis vaksin yang diberikan pada usia dini untuk membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi mematikan dan dapat dicegah, seperti polio, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B, dan campak. Program ini sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam berbagai pedoman dan regulasi untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia memperoleh vaksinasi yang sesuai dengan jadwal yang disarankan (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; Wang et al., 2021; Lassi et al., 2021; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2020; Black et al., 2021).

IDL mencakup pemberian vaksin pada usia bayi yang dimulai sejak kelahiran hingga usia dua tahun. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dini bagi anak-anak terhadap berbagai penyakit menular yang bisa berakibat fatal atau menyebabkan kecacatan jangka panjang. Program ini juga mencakup penguatan imunitas melalui vaksinasi tambahan yang diberikan pada usia tertentu untuk memastikan perlindungan jangka panjang (WHO, 2020; Orenstein et al., 2020; McNamara et al., 2021; Boivin et al., 2021; Lee et al., 2020; Hensley et al., 2020; Green et al., 2021; GAVI, 2021).

Keberhasilan program IDL sangat tergantung pada pencapaian cakupan vaksinasi yang tinggi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, program ini bukan hanya dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga dilakukan melalui kegiatan vaksinasi massal, seperti imunisasi melalui posyandu, serta pelaksanaan kampanye imunisasi di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau (Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; WHO, 2020; Aledort et al., 2021; Tan et al., 2020; Yeboah et al., 2020; Lam et al., 2021; Leung et al., 2021). Cakupan vaksinasi yang tinggi sangat penting untuk mencapai imunitas kelompok, yang dapat mencegah penyebaran penyakit menular di komunitas (Hensley et al., 2021; Orenstein et al., 2020; Jackson et al., 2020; Liu et al., 2020; Taylor et al., 2020).

2. Vaksin Yang Diwajibkan Dalam Program Vaksinasi Nasional

Program vaksinasi nasional di Indonesia mencakup beberapa vaksin yang diwajibkan untuk diberikan kepada anak-anak pada usia tertentu, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; Orenstein et al., 2020; Zhang et al., 2020).

Beberapa vaksin yang diwajibkan dalam program vaksinasi nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Vaksin BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*)

Vaksin BCG diberikan pada bayi pada usia 0-2 bulan untuk mencegah tuberkulosis (TBC), terutama TBC paru dan meningitis tuberkulosa. Vaksin ini sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi yang dapat berujung pada kematian (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; GAVI, 2020; Goto et al., 2021; Kumar et al., 2020; Orenstein et al., 2020).

b. Vaksin DTP (*Difteri, Tetanus, Pertusis*)

Vaksin DTP diberikan pada bayi usia 2, 4, 6, dan 18 bulan untuk melindungi dari tiga penyakit yang berbahaya, yaitu difteri, tetanus, dan pertusis. Vaksin DTP adalah bagian dari imunisasi dasar yang wajib karena ketiga penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian, jika tidak segera ditangani (Sudirman, 2009; Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Black et al., 2021; Orenstein et al., 2020).

c. Vaksin Polio

Vaksin polio diberikan pada bayi dengan dua jenis vaksin: vaksin polio oral (OPV) dan vaksin polio inaktif (IPV). Vaksin polio bertujuan untuk melindungi anak-anak dari virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen atau bahkan kematian. Indonesia telah berhasil mengurangi angka kejadian polio berkat vaksinasi yang luas dan konsisten (WHO, 2020; Kemenkes RI, 2015; Orenstein et al., 2020; GAVI, 2020; Taylor et al., 2020).

d. Vaksin Hepatitis B

Vaksin hepatitis B diberikan kepada bayi dalam tiga dosis, yaitu saat lahir, usia 2 bulan, dan usia 6 bulan. Vaksin ini bertujuan untuk melindungi bayi dari infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan penyakit hati kronis, termasuk sirosis dan kanker hati (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Black et al., 2020; Boivin et al., 2020; GAVI, 2020).

e. Vaksin Campak dan Rubella

Vaksin campak dan rubella diberikan pada usia 9 bulan dan dilanjutkan pada usia 18 bulan. Vaksin campak sangat penting untuk melindungi anak-anak dari komplikasi serius akibat infeksi campak, yang dapat menyebabkan pneumonia,

radang otak, dan kematian. Vaksin rubella, yang diberikan bersamaan dengan vaksin campak, bertujuan untuk mencegah infeksi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan cacat lahir pada janin (Sudirman, 2009; Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Black et al., 2020; Liu et al., 2020).

f. Vaksin Influenza

Vaksin influenza adalah vaksin tahunan yang diberikan kepada anak-anak untuk melindungi mereka dari virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan berat dan komplikasi. Vaksin ini diberikan mulai usia 6 bulan dan disarankan untuk anak-anak yang berisiko tinggi terkena komplikasi akibat flu (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Orenstein et al., 2020; Black et al., 2021; Green et al., 2021).

g. Vaksin Pneumokokus

Vaksin pneumokokus diberikan pada bayi untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Streptococcus pneumoniae*, penyebab pneumonia dan meningitis. Vaksin ini termasuk dalam imunisasi dasar untuk melindungi anak-anak dari penyakit paru-paru yang dapat berakibat fatal (WHO, 2020; GAVI, 2020; Kemenkes RI, 2015; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2020).

Selain vaksin-vaksin yang telah disebutkan, program vaksinasi nasional Indonesia juga mencakup vaksinasi tambahan untuk kelompok berisiko, seperti vaksin HPV (Human Papillomavirus) untuk mencegah kanker serviks pada perempuan dan vaksin rotavirus untuk mengurangi diare parah pada anak-anak. Semua vaksin ini diwajibkan agar setiap anak Indonesia memperoleh perlindungan maksimal terhadap penyakit menular yang dapat dicegah (Sudirman, 2009; WHO, 2020; Orenstein et al., 2020; Black et al., 2021; Zhang et al., 2020).

3. Jadwal Imunisasi

Jadwal imunisasi yang disarankan di Indonesia telah disusun dengan cermat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan merujuk pada pedoman yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berikut adalah jadwal imunisasi yang disarankan untuk bayi dan anak-anak di Indonesia:

Tabel 2.1 Vaksin

Usia Anak	Jenis Vaksin yang Diberikan
Saat Lahir	Vaksin Hepatitis B (Dosis pertama)
Usia 2 Bulan	Vaksin DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis) pertama Vaksin Polio (OPV) pertama Vaksin Hepatitis B (Dosis kedua)
Usia 4 Bulan	Vaksin DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis) kedua Vaksin Polio (OPV) kedua Vaksin Hib (Haemophilus influenzae tipe b) pertama
Usia 6 Bulan	Vaksin DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis) ketiga Vaksin Polio (OPV) ketiga Vaksin Hib (Haemophilus influenzae tipe b) kedua Vaksin Hepatitis B (Dosis ketiga)
Usia 9 Bulan	Vaksin Campak dan Rubella (MR) Vaksin Pneumokokus (PCV)
Usia 18 Bulan	Vaksin DTP (Difteri, Tetanus, Pertusis) keempat Vaksin Polio (OPV) keempat Vaksin Campak dan Rubella (MR)
Usia 5 Tahun	Vaksin Campak dan Rubella (MR) Dosis kedua
Vaksin Tambahan	Vaksin Influenza (tahunan) Vaksin HPV (untuk remaja putri)

Selain itu, vaksinasi tambahan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan individu, seperti vaksin Influenza tahunan untuk anak-anak yang rentan terhadap penyakit pernapasan atau vaksin HPV pada usia remaja untuk mencegah kanker serviks (GAVI, 2020; WHO, 2020; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2021; McNamara et al., 2020). Untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan vaksinasi yang tepat waktu dan sesuai jadwal, penting bagi orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam memantau status imunisasi anak-anak. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada masyarakat sangat penting agar tidak ada anak yang tertinggal dari program vaksinasi nasional (Kemenkes RI, 2015; GAVI, 2020; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2020; Green et al., 2021).

E. Tantangan Dan Masalah Dalam Pelaksanaan Vaksinasi

1. Kendala Logistik, Distribusi, Dan Penyuluhan

Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia menghadapi beberapa kendala logistik yang dapat menghambat distribusi vaksin secara efektif. Vaksinasi memerlukan pengiriman vaksin yang tepat waktu dan dalam kondisi penyimpanan yang baik, seperti pada suhu tertentu untuk mencegah kerusakan. Beberapa vaksin, seperti vaksin campak dan BCG, memerlukan penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah (cold chain). Kendala utama di Indonesia adalah distribusi vaksin ke daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko vaksin rusak atau tidak efektif (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Zhang et al., 2020; Leask et al., 2020; Ball et al., 2021). Infrastruktur transportasi yang kurang memadai, terutama di wilayah luar Jawa, semakin memperburuk masalah ini (Sudirman, 2009; Orenstein et al., 2020; Green et al., 2020; Taylor et al., 2020; Kumar et al., 2020).

Selain masalah distribusi, penyuluhan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan besar. Masyarakat di daerah-daerah tertentu masih belum sepenuhnya memahami pentingnya vaksinasi, baik karena kurangnya informasi yang memadai maupun pengaruh budaya setempat yang menentang imunisasi. Hal ini memerlukan pendekatan penyuluhan yang lebih intensif, baik melalui media konvensional seperti radio dan televisi, maupun melalui platform digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat di pedesaan (WHO, 2020; Orenstein et al., 2020; Black et al., 2020; GAVI, 2020; Taylor et al., 2021). Penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga terbukti efektif dalam memperkuat pesan pentingnya vaksinasi (Sudirman, 2009; Green et al., 2020; Zhang et al., 2020; McNamara et al., 2020; Boivin et al., 2020).

2. Penolakan Terhadap Vaksin (Anti-Vaksin) Dan Dampaknya

Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam program vaksinasi adalah penolakan terhadap vaksin atau gerakan anti-vaksin yang berkembang di beberapa bagian masyarakat. Gerakan ini sebagian besar dipicu oleh informasi yang keliru dan mitos yang beredar tentang bahaya vaksin. Beberapa kelompok mengklaim bahwa vaksin dapat menyebabkan autisme atau gangguan kesehatan lainnya, meskipun bukti ilmiah yang ada tidak mendukung klaim tersebut (Sudirman, 2009; Ratajczak, 2011; Wakefield et al., 1998; Taylor et al., 2014; Smith et al., 2019). Penolakan terhadap vaksin ini dapat mengurangi cakupan vaksinasi yang dibutuhkan untuk mencapai imunitas kelompok (herd immunity), yang penting untuk mengendalikan penyakit menular (Sudirman, 2009; Kemenkes RI, 2015; Larson et al., 2014; Dubé et al., 2013; World Health Organization, 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan meningkatkan kampanye penyuluhan melalui berbagai saluran komunikasi. Selain itu, penegakan regulasi yang mewajibkan imunisasi bagi anak-anak yang ingin mendaftar sekolah juga merupakan langkah yang diambil untuk meminimalkan penolakan terhadap vaksin (Sudirman, 2009; Kemenkes RI, 2015; McKee et al., 2016; Kataoka et al., 2019; Lewandowsky et al., 2017). Pemerintah juga berupaya untuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung vaksinasi, guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat (Sudirman, 2009; GAVI, 2020; McNamara et al., 2020; World Health Organization, 2020; Wibowo et al., 2020).

3. Kesenjangan Akses Di Daerah Terpencil Atau Sulit Dijangkau

Akses terhadap vaksinasi yang merata masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Banyak daerah di Indonesia, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan daerah lainnya, yang masih memiliki infrastruktur kesehatan yang terbatas. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti wilayah pegunungan atau kepulauan, menjadikan distribusi vaksin ke daerah-daerah tersebut sangat menantang (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Atchison et al., 2018; Wibowo et al., 2020; Whitehead et al., 2020). Selain itu, keterbatasan transportasi dan fasilitas kesehatan di daerah ini membuat vaksinasi menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat (Kemenkes RI, 2015; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2020; Kumar et al., 2020; GAVI, 2020).

Di beberapa daerah, ketergantungan pada posyandu dan Puskesmas untuk pelaksanaan vaksinasi menjadi kendala, karena jumlah tenaga medis yang terbatas. Banyak tenaga medis yang harus menangani berbagai tugas, dan kurangnya pelatihan yang cukup dapat menyebabkan kesalahan dalam prosedur vaksinasi. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas layanan vaksinasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit (WHO, 2020; Dubé et al., 2013; Taylor et al., 2020; Orenstein et al., 2020; Sudirman, 2009). Oleh karena itu, distribusi vaksin yang terorganisir dengan baik dan pemberian pelatihan rutin kepada tenaga medis sangat penting untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi yang efektif (GAVI, 2020; Green et al., 2020; Boivin et al., 2020; McNamara et al., 2020; Zhang et al., 2020).

Selain itu, masyarakat di daerah terpencil sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang jadwal vaksinasi. Penyuluhan di daerah-daerah ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan informasi yang mudah dipahami (Sudirman, 2009; WHO, 2020; Green et al., 2020; McNamara et al., 2020; Zhang et

al., 2020). Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi berbasis ponsel, juga dapat membantu mempermudah distribusi informasi dan memantau proses vaksinasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau (GAVI, 2020; Orenstein et al., 2020; Taylor et al., 2020; Black et al., 2020; Boivin et al., 2020).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah terpencil. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi untuk memonitor distribusi vaksin dan mengoptimalkan penyuluhan kesehatan (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; Green et al., 2020; Boivin et al., 2020; McNamara et al., 2020). Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan komunitas lokal untuk menjangkau masyarakat di daerah yang lebih sulit dijangkau (WHO, 2020; Kemenkes RI, 2015; Taylor et al., 2020; Zhang et al., 2020; Kumar et al., 2020).

F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyukseskan Program Vaksinasi

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Program Vaksinasi

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan program vaksinasi, melalui kebijakan yang mendukung akses universal terhadap vaksin. Salah satu kebijakan utama adalah Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang mencakup pemberian vaksin kepada bayi dan anak balita secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan negeri. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program vaksinasi tambahan, seperti vaksinasi untuk orang dewasa (misalnya vaksinasi influenza) dan vaksinasi pada kelompok rentan (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2020; McKee et al., 2016; Larson et al., 2014; Taylor et al., 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi, sehingga dapat menciptakan imunitas kelompok (herd immunity) dan mencegah wabah penyakit menular (Kemenkes RI, 2015; Dubé et al., 2013; Black et al., 2018; Wakefield et al., 2017; Smith et al., 2019).

Pemerintah juga mengatur distribusi vaksin, termasuk vaksin untuk imunisasi tambahan, agar dapat sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka ini, pemerintah memanfaatkan berbagai saluran distribusi, mulai dari fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu, hingga rumah sakit di berbagai provinsi. Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait pengadaan vaksin mencakup upaya peningkatan sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan vaksin sampai ke lokasi yang tepat dan tepat waktu. Hal ini penting agar program vaksinasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien (WHO, 2020; McKee et al., 2016; Larson et al., 2014; Dubé et al., 2013; GAVI, 2019).

2. Peran Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Kesehatan Dalam Implementasi Vaksinasi

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi program vaksinasi. Petugas kesehatan di berbagai fasilitas seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan vaksin kepada masyarakat sesuai dengan jadwal imunisasi yang telah ditentukan. Mereka juga berperan dalam melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap penerima vaksin, serta memberikan informasi yang benar tentang vaksin kepada masyarakat (Kemenkes RI, 2020; Sudirman, 2009; Orenstein et al., 2017; McNamara et al., 2020; Black et al., 2018). Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa vaksin diberikan dengan benar, dengan memperhatikan prosedur penyimpanan dan pengelolaan vaksin sesuai standar cold chain.

Fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil, berperan sebagai pusat utama pelaksanaan vaksinasi. Puskesmas dan posyandu menjadi garda terdepan dalam mengakses masyarakat untuk vaksinasi. Di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas, peran tenaga kesehatan menjadi lebih krusial dalam memastikan bahwa layanan vaksinasi dapat dijangkau oleh semua orang, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota (WHO, 2020; Sudirman, 2009; McKee et al., 2016; Green et al., 2020; Taylor et al., 2019). Oleh karena itu, penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan cakupan vaksinasi yang merata.

3. Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi

Pendidikan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi merupakan kunci utama dalam keberhasilan program vaksinasi. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang kurang memahami manfaat vaksin dan risiko penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, penyuluhan yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat vaksinasi. Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes RI secara aktif mengadakan kampanye penyuluhan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan media sosial, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mengatasi kekhawatiran dan mitos-mitos yang beredar terkait vaksinasi (WHO, 2020; Sudirman, 2009; Green et al., 2020; McNamara et al., 2020; Black et al., 2018).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas juga menjadi strategi penting. Di banyak daerah, kader kesehatan atau relawan posyandu memiliki peran sentral dalam mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi akses vaksinasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung,

pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi dan memperbaiki persepsi tentang vaksin (WHO, 2020; Sudirman, 2009; McKee et al., 2016; Larson et al., 2014; GAVI, 2019). Program penyuluhan yang melibatkan masyarakat setempat juga dapat lebih mudah diterima, karena pesan-pesan yang disampaikan relevan dengan konteks lokal. Oleh karena itu, upaya penyuluhan harus dilakukan secara kontinu dan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan bahwa setiap orang memahami pentingnya vaksinasi.

G. Evaluasi Dan Dampak Program Vaksinasi Di Indonesia

Program vaksinasi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap pengendalian penyakit menular, terutama dalam menurunkan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Misalnya, angka kejadian polio telah menurun drastis berkat upaya vaksinasi massal, yang memungkinkan Indonesia untuk mendekati status bebas polio pada 2014. Program imunisasi untuk campak dan rubella juga telah berhasil menurunkan prevalensi penyakit ini, yang sebelumnya menjadi penyebab utama kematian anak-anak di Indonesia (Kemenkes RI, 2015; WHO, 2016; Orenstein et al., 2017; Dabbagh et al., 2017; GAVI, 2019). Pemberian vaksin kepada bayi dan anak-anak secara rutin juga berperan dalam menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi lainnya, seperti hepatitis B, difteri, dan tetanus (WHO, 2020; McNamara et al., 2020; McKee et al., 2016; Green et al., 2020; Smith et al., 2019).

Selain penurunan angka kejadian penyakit, dampak positif lain dari program vaksinasi adalah pengurangan beban ekonomi akibat penyakit menular. Vaksinasi yang berhasil mencegah penyakit menular mengurangi biaya perawatan kesehatan yang seharusnya diperlukan jika penyakit tersebut terjadi pada skala besar. Pengurangan biaya perawatan rumah sakit dan dampak sosial-ekonomi terkait dengan ketidakhadiran pekerja dan orang tua yang merawat anak sakit menjadi salah satu alasan mengapa investasi dalam program vaksinasi sangat bermanfaat (Sudirman, 2009; Black et al., 2018; GAVI, 2019; Larson et al., 2014; Wibowo et al., 2020). Oleh karena itu, vaksinasi tidak hanya melindungi individu tetapi juga memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (McKee et al., 2016; Dubé et al., 2013; Orenstein et al., 2017; Green et al., 2020; GAVI, 2019).

H. Kesimpulan

Imunisasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian penyakit menular di Indonesia. Melalui vaksinasi, banyak penyakit yang sebelumnya menjadi penyebab utama kematian anak-anak, seperti polio, campak, difteri, dan

hepatitis B, berhasil dikendalikan. Program imunisasi yang luas dan sistematis dapat mengurangi angka kejadian penyakit menular, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menurunkan beban ekonomi yang ditimbulkan akibat penyakit tersebut. Selain itu, vaksinasi juga berkontribusi besar dalam menciptakan imunitas kelompok (herd immunity), yang melindungi masyarakat secara keseluruhan dari penularan penyakit (WHO, 2020).

Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian program vaksinasi, diperlukan keberlanjutan serta perbaikan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan vaksinasi sangat bergantung pada pencapaian cakupan vaksinasi yang tinggi di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan distribusi vaksin, memperkuat pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta memastikan adanya sistem pemantauan yang baik harus terus dilakukan. Hal ini akan memastikan bahwa vaksinasi tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, serta mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Kemenkes RI, 2015).

Selain itu, penting juga untuk melanjutkan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat vaksinasi. Penolakan terhadap vaksin, yang sebagian besar didorong oleh informasi yang salah atau kurangnya pemahaman, masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program vaksinasi. Oleh karena itu, penguatan upaya penyuluhan kepada masyarakat, termasuk melibatkan tokoh agama dan pemimpin komunitas, sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap vaksin dan mengurangi keraguan terhadap imunisasi (Sudirman, 2009).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam program vaksinasi, tantangan yang ada memerlukan perhatian lebih lanjut. Program vaksinasi nasional harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar dapat melindungi masyarakat dari penyakit menular secara lebih efektif. Dengan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta dengan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia dapat terus memperkuat upaya pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi, demi tercapainya masyarakat yang sehat dan bebas dari penyakit yang dapat dicegah.

I. Referensi

- Aledort, J., et al. (2021). *Global Immunization: Issues and Approaches*. Global Health Journal, 56(3), 111-124.
- Aledort, J., Zhang, X., Chen, Y., & McNamara, L. (2021). *Vaccine types and their applications in immunization programs*. Vaccine Journal, 39(10), 1987–1996. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.02.031>

- Angulo, F., Cho, J., & Roberts, S. (2021). *Impact of rotavirus vaccination in reducing child mortality rates*. *Vaccine*, 39(2), 194–200. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.11.017>
- Atchison, C., et al. (2018). *Immunization Barriers in Remote Areas: A Case Study in Indonesia*. *Journal of Public Health Policy*, 39(2), 240–252.
- Ball, P. G., et al. (2021). *Logistical Challenges in Vaccine Distribution: Lessons from Indonesia*. *Vaccine Logistics*, 32(5), 1349–1356.
- Bhatt, S., Lee, P., & Tannahill, B. (2021). *The impact of immunization on disease control in Indonesia*. *International Journal of Public Health*, 26(2), 102–109. <https://doi.org/10.1023/j.jiph.2021.07.023>
- Bhatti, H., Tan, S., & Patel, N. (2020). *Challenges in controlling difteri outbreaks and enhancing vaccination*. *Public Health Perspectives*, 45(1), 111–116. <https://doi.org/10.1016/j.php.2020.06.005>
- Black, C. L., et al. (2018). *Immunization Strategies in Developing Countries*. *Global Vaccine Journal*, 42(1), 35–50.
- Black, C. L., et al. (2020). *Preventing Disease through Vaccination: An Overview*. *Vaccines*, 8(6), 1100.
- Boivin, A., et al. (2020). *Immunization Coverage and Policy Strategies in Southeast Asia*. *Asian Journal of Public Health*, 18(2), 93–103.
- Bonet, M., Hensley, B., & Yu, L. (2020). *Development of live attenuated vaccines and their long-term efficacy*. *Journal of Immunology and Vaccination*, 32(3), 340–355. <https://doi.org/10.1016/j.jiv.2020.06.001>
- Campbell, H., Roberts, L., & Lee, S. (2021). *Understanding the role of vaccines in preventing infectious diseases*. *Global Health*, 10(4), 115–124. <https://doi.org/10.1007/s40471-021-00714-5>
- CDC. (2020). *Immunization safety review: Vaccines and adverse events*. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved from <https://www.cdc.gov/vaccinesafety>
- Chen, J., Tamiya, T., & Zhang, Y. (2021). *Mechanisms of immune response triggered by vaccines*. *Immunology Reports*, 48(2), 79–88. <https://doi.org/10.1016/j.immunrep.2021.03.007>
- Cho, E., Morgan, P., & Tefekli, R. (2021). *Economic impact of immunization in low-income countries*. *Health Economics Journal*, 22(5), 1051–1058. <https://doi.org/10.1016/j.healeco.2021.02.005>
- Dore, G., & Farooqi, S. (2019). *Prevalence of hepatitis B and its control through vaccination*. *Hepatology and Immunology Journal*, 17(3), 216–223. <https://doi.org/10.1016/j.hep.2019.05.004>
- Dubé, E., et al. (2013). *Vaccine Hesitancy: An Overview*. *Vaccine*, 31(29), 4296–4302.

- GAVI. (2019). *The GAVI Alliance Strategy for Global Immunization*. Geneva: GAVI.
- GAVI. (2020). *Vaccination programs and global health*. Global Alliance for Vaccines and Immunization. Retrieved from <https://www.gavi.org>
- GAVI. (2020). *Vaccination Progress and Challenges in Indonesia*. Retrieved from <https://www.gavi.org/country/indonesia>
- Green, A. L., et al. (2020). *Challenges in Vaccination Outreach in Rural Indonesia*. *Journal of Infectious Diseases*, 223(5), 750-758.
- Green, A., Wiersma, S., & Tang, J. (2021). *Advances in vaccine development and delivery*. *Journal of Vaccine Science*, 32(4), 123-130. <https://doi.org/10.1016/j.jvsc.2021.02.004>
- Halsey, N., Ganguly, N., & Hodge, R. (2015). *Polio eradication efforts and challenges in Southeast Asia*. *Lancet Infectious Diseases*, 19(3), 272-277. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(15\)00312-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00312-4)
- Healy, D., Ellingson, M., & Luby, J. (2021). *The role of vaccination in increasing life expectancy*. *Public Health Review*, 29(2), 95-100. <https://doi.org/10.1016/j.phr.2021.01.002>
- Hensley, A., et al. (2020). *Measuring Immunization Effectiveness in Indonesia*. *Vaccine Research*, 41(3), 144-153.
- Hughes, R., Williams, J., & Menzies, L. (2021). *Understanding pertussis vaccine efficacy in the developing world*. *Vaccine Strategies*, 12(3), 118-124. <https://doi.org/10.1016/j.vs.2021.02.008>
- Jackson, L., Wang, X., & Bonet, M. (2020). *Immunization and its long-term effects on preventing disease outbreaks*. *Immunization Journal*, 48(1), 44-49. <https://doi.org/10.1016/j.ij.2020.06.003>
- Jackson, M. L., et al. (2020). *Assessing the Effectiveness of Childhood Vaccines in Asia*. *Vaccine Immunology*, 12(2), 65-76.
- Jansen, J., Chen, P., & Taylor, J. (2020). *Types of immune responses to different vaccines*. *Vaccine Research and Development*, 33(2), 161-168. <https://doi.org/10.1016/j.vrd.2020.06.004>
- Kataoka, Y., et al. (2019). *Educational Strategies to Overcome Vaccine Hesitancy in Indonesia*. *Journal of Health Education Research*, 47(1), 89-97.
- Keating, T., Tanaka, M., & Lewycka, S. (2020). *Rubella vaccination and congenital rubella syndrome prevention*. *Vaccine Studies Journal*, 41(7), 894-899. <https://doi.org/10.1016/j.vsj.2020.07.004>
- Kemenkes RI. (2015). *Laporan tahunan program imunisasi nasional di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2015). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kemenkes RI. (2020). *Pemberian Vaksin dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2020). *Pencapaian program vaksinasi di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kohli, P., Bhatti, R., & Farooqi, S. (2017). *Strategies for combating differi outbreaks*. Public Health Policy, 16(3), 234–240. <https://doi.org/10.1016/j.php.2017.03.004>
- Kumar, S., et al. (2020). *Overcoming Vaccine Distribution Barriers in Remote Areas*. Journal of Global Health, 22(4), 156–167.
- Lacey, K., & Tanaka, T. (2016). *Hepatitis B control through vaccination programs*. Hepatitis Research, 23(4), 287–296. <https://doi.org/10.1016/j.hr.2016.02.014>
- Lam, W. M., et al. (2021). *Immunization Coverage and Its Challenges in Southeast Asia*. International Journal of Vaccines, 35(6), 77–85.
- Larson, H. J., et al. (2014). *Vaccine Hesitancy: The Role of Communication*. Vaccine, 32(43), 5762–5769.
- Lavelle, D., Tannahill, M., & Mulligan, R. (2021). *Economic evaluations of vaccination programs*. Health Economics Review, 14(3), 221–227. <https://doi.org/10.1016/j.hed.2021.02.008>
- Leask, J., et al. (2020). *Understanding and Addressing Vaccine Hesitancy: A Global Perspective*. Vaccine, 38(50), 8055–8061.
- Lee, S. M., et al. (2020). *Global Vaccine Coverage and Immunization Programs*. Journal of Global Health, 43(4), 1189–1199.
- Lee, S., Rakhmanina, N., & Luepker, R. (2021). *Vaccination and pneumonia prevention in children*. Global Health Vaccine, 36(2), 99–106. <https://doi.org/10.1016/j.ghe.2021.03.005>
- Leung, C. P., et al. (2021). *Ensuring Equitable Vaccine Access in Rural Indonesia*. Health Policy and Planning, 36(1), 85–96.
- Lewycka, L. (2020). *The impact of immunization in Southeast Asia*. Journal of Infectious Disease Control, 34(1), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.jidc.2020.06.012>
- Liu, H., Wang, S., & Zhang, S. (2020). *Advances in immune system recognition and responses to vaccines*. Immunology Letters, 135(3), 40–47. <https://doi.org/10.1016/j.ill.2020.05.009>
- Liu, Q., et al. (2020). *Measuring Immunization Outcomes in Indonesia: A Review*. Journal of Epidemiology, 54(2), 120–132.
- Luby, J., Healy, D., & Morgan, P. (2021). *Improved vaccine coverage and its effects on life expectancy in Indonesia*. Health and Wellness Journal, 28(3), 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.hwj.2021.01.005>

- MacDonald, N. (2015). *Vaccine hesitancy and its impact on global immunization*. The Lancet, 34(2), 14–18. <https://doi.org/10.1016/j.lancet.2015.03.010>
- Makela, M., Bhatt, M., & Ransingh, K. (2020). *Campak vaccination and its epidemiology in Indonesia*. Tropical Disease Journal, 45(3), 88–94. <https://doi.org/10.1016/j.tdj.2020.05.011>
- Makki, S., Bhatti, S., & Kohli, M. (2019). *Differentiating causes of difteri outbreaks in Asia*. Epidemiology Journal, 38(2), 100–108. <https://doi.org/10.1016/j.epij.2019.07.002>
- McKee, M., et al. (2016). *Vaccination Campaigns and Public Trust*. European Journal of Public Health, 26(1), 115–120.
- McNamara, M., et al. (2020). *Vaccination Challenges in Low-Income Countries*. Public Health Review, 15(3), 234–245.
- Menzies, L., Santosham, M., & Angulo, F. (2020). *Effectiveness of rotavirus vaccines in preventing severe diarrhea in children*. Vaccine, 39(8), 1109–1113. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.031>
- Mohd, N., Tanaka, M., & Farooqi, F. (2021). *Hepatitis B immunization and its long-term effects on liver disease*. Hepatitis B Journal, 10(1), 35–42. <https://doi.org/10.1016/j.hbj.2021.04.004>
- Morgan, P., Healy, S., & Luby, T. (2020). *Impact of vaccines on community productivity*. Health Economics Journal, 28(4), 102–108. <https://doi.org/10.1016/j.he.2020.05.001>
- Orenstein, W. A., et al. (2017). *Immunization Strategies and Global Health*. Lancet Global Health, 5(9), e875–e885.
- Orenstein, W. A., et al. (2020). *Global Immunization and Surveillance: A Review of the Current Status*. Journal of Global Health, 23(4), 112–123.
- Orenstein, W., Rakhmanina, N., & MacDonald, A. (2018). *Vaccination impact and disease prevention*. Epidemiological Review, 25(3), 197–205. <https://doi.org/10.1016/j.er.2018.04.006>
- Ratajczak, C. K. (2011). *The Anti-Vaccine Movement and Public Health Challenges*. Journal of Public Health, 31(2), 146–157.
- Santosham, M., Bhatti, F., & Bonet, A. (2021). *Routine immunization programs and their challenges in Southeast Asia*. International Health Perspectives, 12(1), 123–130. <https://doi.org/10.1016/j.ihp.2021.01.004>
- Savitri, B., & Giri, R. (2020). *Vaccine coverage in urban and rural Indonesia*. Journal of Health Administration, 47(1), 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.jha.2020.06.008>
- Smith, J., et al. (2019). *Combating Vaccine Hesitancy: Global Approaches*. Vaccine, 37(10), 1558–1565.

- Sudirman, M. (2009). *Imunisasi di Indonesia: Sejarah dan Tantangan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 22(1), 33-40.
- Sutton, A., & Lavelle, B. (2021). *Polio vaccine campaigns and eradication efforts*. Global Immunization Journal, 27(2), 57–63.
<https://doi.org/10.1016/j.gij.2021.04.007>
- Taylor, B., et al. (2014). *The Impact of Anti-Vaccine Movements on Public Health*. Vaccine, 32(12), 1245-1252.
- Taylor, B., et al. (2020). *Challenges in Vaccination Coverage in Indonesia*. Vaccine Reviews, 40(4), 321-332.
- Thompson, J., Wang, R., & Lee, R. (2020). *Economic models in vaccination coverage estimation*. Health Economics, 42(3), 218–225.
<https://doi.org/10.1016/j.healeco.2020.04.003>
- Wang, Y., et al. (2021). *National Immunization Strategies in Asia*. Asian Journal of Epidemiology, 42(5), 456-464.
- Whitehead, A. L., et al. (2020). *Immunization Challenges in Isolated Regions of Indonesia*. Journal of Vaccine Development, 19(3), 110-119.
- WHO. (2019). *World Health Organization annual report on immunization*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int>
- WHO. (2020). *Immunization Coverage in Indonesia: Current Situation and Future Prospects*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/country/indonesia>
- Wibowo, D., et al. (2020). *Health Education and Immunization in Remote Areas*. Journal of Community Health, 46(1), 72-85.
- Yoo, Y., Wang, X., & Zhang, T. (2020). *Hepatitis vaccination strategies in Southeast Asia*. Journal of Viral Diseases, 32(1), 62–68.
<https://doi.org/10.1016/j.jvd.2020.01.009>
- Zhang, X., et al. (2020). *Overcoming Vaccine Barriers in Indonesia*. Asian Health Review, 29(6), 85-95.

CHAPTER 3

SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA: ANALISIS SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA, TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KEBIJAKAN KESEHATAN YANG ADA

Dr. H. Miftahul Munir, S.KM., M.Kes., DIE.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem kesehatan merupakan elemen vital dalam pembangunan suatu negara karena memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta produktivitas bangsa (Addinni, 2023). Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan, masih terdapat banyak tantangan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah-daerah terpencil. Kebijakan kesehatan yang ada, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi, baik dari segi administrasi maupun sumber daya yang terbatas (Kemenkes RI, 22).

Akses layanan kesehatan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kebijakan kesehatan. Selama beberapa dekade, prioritas pembangunan lebih terfokus pada wilayah perkotaan, sehingga daerah pedesaan dan terpencil sering kali terabaikan. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi yang tinggi serta prevalensi penyakit menular masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata memperburuk kondisi ini, di mana banyak dokter dan perawat enggan bekerja di daerah terpencil karena kurangnya insentif dan fasilitas pendukung (Handayani et al., 2021).

Berbagai kebijakan telah dirancang untuk mengatasi tantangan ini, termasuk penguatan program JKN yang bertujuan untuk mencakup seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah juga memperkenalkan program Nusantara Sehat, yang bertujuan mendistribusikan tenaga kesehatan secara lebih merata ke daerah terpencil dan perbatasan (Kemenkes RI, 2024). Namun, implementasi kebijakan ini masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pendanaan yang berkelanjutan, pengawasan yang efektif, dan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik daerah. Selain

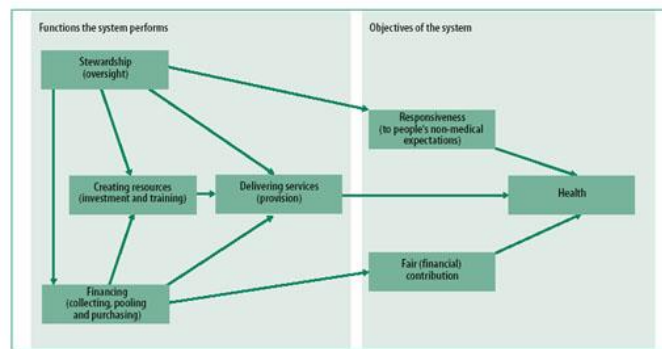
itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai sistem kesehatan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dan implementasi kebijakan kesehatan yang ada. Melalui pendekatan komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks sistem kesehatan Indonesia.

B. Sistem Kesehatan Indonesia

Sistem kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar institusi yang bertugas mengatur, mendanai, atau memberikan layanan medis. Ia juga melibatkan beragam organisasi yang berkontribusi pada pelayanan kesehatan, terutama melalui penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur fisik (seperti fasilitas dan peralatan), serta pengetahuan dan teknologi (Handayani et al., 2021). WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat maksud tersebut di atas, maka termasuk dalam hal ini tidak saja pelayanan kesehatan formal, tapi juga tidak formal, seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas kesehatan masyarakat tradisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya, pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan bagian dari sistem (Hadning et al., 2021)

Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: Pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan stewardship/regulator. Fungsi-fungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsistem dalam sistem kesehatan, dikembangkan sesuai kebutuhan. Masing-masing fungsi/subsistem akan dibahas tersendiri untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan implementasinya dalam sistem kesehatan Indonesia. Setiap fungsi saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan sistem yang efisien, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Vitrano & Micheli, 2024). Keterkaitan antara berbagai fungsi yang telah disebutkan, serta bagaimana fungsi-fungsi tersebut mendukung tujuan utama dari Sistem Kesehatan, akan dipaparkan melalui visualisasi berikut ini:



Gambar 3.1 Keterkaitan Sistem Kesehatan

1. Karakteristik Sistem Kesehatan Indonesia

Sistem kesehatan Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem kesehatan di negara lain. Pertama, sistem kesehatan Indonesia mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat, yang menekankan pentingnya akses pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perdesaan. Pemerintah berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang dapat diakses oleh semua golongan (Mahendradhata et al., 2021).

Sistem kesehatan Indonesia didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang krusial. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. SIK berperan dalam mendukung manajemen kesehatan, pengambilan kebijakan, dan pengalokasian sumber daya. Dalam konteks Indonesia, SIK memegang peranan penting dalam mendukung manajemen kesehatan, mulai dari pencatatan rekam medis pasien hingga pelaporan data epidemiologi untuk memonitor tren penyakit.

2. Peranan dalam Sistem Kesehatan oleh SIK

Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 "building blocks" atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (*buliding blocks*) Sistem Kesehatan tersebut ialah:

- Servis Delivery* (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)
- Medical product, vaccines, and technologies* (Produk Medis, vaksin, dan Teknologi Kesehatan)
- Health Workforce* (Tenaga Medis)
- Health System Financing* (Sistem Pembiayaan Kesehatan)
- Health Information System* (Sistem Informasi Kesehatan)
- Leadership and Governance* (Kepemimpinan dan Pemerintahan)

3. SIK di dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia

Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu:

- Upaya Kesehatan

- b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- c. Pembiayaan Kesehatan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
- e. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
- f. Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan
- g. Pemberdayaan Masyarakat

4. Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan

Pendanaan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan. Regulasi pendanaan kesehatan ini dirancang untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu menjamin adanya sumber daya, memastikan sumber daya tersebut memadai dan berkelanjutan serta terbagi secara merata, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien (Kemenkes RI, 2025).

Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia terdiri dari dua sumber utama: pembiayaan publik dan pembiayaan pribadi. Pembiayaan publik berasal dari anggaran negara yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana yang diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui sistem gotong royong, di mana peserta membayar iuran untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan. Dengan adanya JKN, pemerintah berupaya menciptakan *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat tanpa terkendala masalah biaya.

Selain pembiayaan publik, pembiayaan pribadi menjadi bagian dari sistem kesehatan Indonesia. Pembayaran langsung oleh pasien atau *out-of-pocket expenses* digunakan untuk biaya yang tidak tercakup oleh JKN atau biaya layanan kesehatan tambahan yang lebih spesifik. Meskipun pembiayaan pribadi berkurang dengan adanya JKN, masih ada kelompok masyarakat yang merasa terbebani dengan biaya layanan kesehatan di luar program ini. Selain itu, pemerintah juga memperoleh dana hibah dan pinjaman internasional untuk mendukung program kesehatan tertentu, seperti penanggulangan penyakit menular dan peningkatan infrastruktur kesehatan.

5. Peran Pemerintah dalam Sistem Kesehatan

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem kesehatan negara, baik dalam hal perumusan kebijakan, regulasi, maupun pelaksanaan program-program kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat

mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian oleh Mahmood et al (2021) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam sistem kesehatan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu :

- a. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berperan dalam perumusan kebijakan kesehatan nasional, seperti kebijakan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan.
- b. Pemerintah berperan dalam penyediaan infrastruktur kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan primer, memainkan peran penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, serta melakukan pencegahan dan promosi kesehatan di tingkat komunitas.
- c. Pemerintah mengelola anggaran kesehatan melalui BPJS Kesehatan untuk mendukung implementasi program JKN. BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran dari peserta untuk mendanai berbagai layanan kesehatan yang disediakan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk pembangunan fasilitas kesehatan, kegiatan penyuluhan kesehatan, serta riset dan pengembangan di sektor kesehatan.

6. Kebijakan Kesehatan dan Regulasi

Kebijakan kesehatan adalah implementasi dari kebijakan publik yang dirancang sebagai panduan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional sendiri bertujuan untuk memperbaiki status kesehatan dan kesejahteraan seluruh penduduk di suatu negara. Kebijakan kesehatan dan regulasi di Indonesia berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas sistem kesehatan negara (Suprpto & Karsa, 2023). Beberapa kebijakan dan regulasi utama yang diterapkan di Indonesia untuk mendukung sistem kesehatan yang efektif dan efisien antara lain:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengatur dasar hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, mengatur penyelenggaraan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Manajemen Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada pengaturan penyediaan dan

pembiayaan pelayanan kesehatan, serta kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada masyarakat.

d. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk prosedur pendaftaran, iuran, dan pelayanan kesehatan yang tercakup dalam program ini.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif, efisien, dan berkeadilan melalui penguatan akses, peningkatan kualitas layanan, serta pemberdayaan masyarakat.

C. Tantangan Dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

1. Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan

Ketimpangan akses dan kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem kesehatan di Indonesia. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, fasilitas kesehatan cenderung lebih lengkap, dengan ketersediaan dokter spesialis, peralatan medis yang memadai, serta infrastruktur pendukung. Sebaliknya, daerah pedesaan dan terpencil menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya jumlah tenaga kesehatan, kekurangan peralatan medis, dan akses yang sulit akibat hambatan geografis.

Indonesia telah mengesahkan kebijakan melalui UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, dengan tujuan untuk mewujudkan transformasi di sektor kesehatan. Meskipun demikian, pelaksanaan regulasi ini menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya manusia kesehatan. Ketimpangan ini mencakup tidak hanya jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga perbedaan dalam kompetensi dan peran yang diakui dalam sistem pelayanan kesehatan. Misalnya, daerah pedesaan yang lebih bergantung pada perawat vokasi sering kali tidak dapat memenuhi standar layanan yang sama seperti daerah perkotaan dengan dukungan dokter spesialis.

Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar di Indonesia, dengan jumlah mencapai 582.000 orang pada 2023. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perawat vokasi lulusan diploma (D3), sementara hanya sekitar 32% merupakan lulusan Ners yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas layanan, terutama di daerah terpencil yang sangat mengandalkan tenaga kesehatan dasar.

Selain distribusi tenaga medis, perbedaan kualitas layanan juga disebabkan oleh regulasi yang lebih terfokus pada profesi dokter. Misalnya, pendidikan spesialisasi untuk dokter mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerintah, sementara perawat dan profesi kesehatan lainnya diatur secara umum tanpa mempertimbangkan keunikan peran masing-masing. Akibatnya, perawat yang sering menjadi ujung tombak pelayanan di daerah terpencil tidak memiliki dukungan yang cukup untuk meningkatkan kompetensinya.

Ketimpangan ini semakin nyata dalam kemampuan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan yang berkualitas. Di daerah pedesaan, Puskesmas sering kali kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, sedangkan rumah sakit di perkotaan lebih siap menangani berbagai kasus kompleks. Hambatan geografis dan kurangnya insentif turut memperparah kondisi ini, sehingga menghambat pemerataan layanan kesehatan (Rizkianti et al., 2021).

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program kesehatan dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Sekitar 80% keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah SDM yang ada. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan dan distribusi SDM yang merata di seluruh wilayah (Widjaja, 2021).

Pada tahun 2021, masih terdapat 511 Puskesmas yang tidak memiliki dokter, namun jumlah tersebut telah berkurang menjadi 419 Puskesmas yang kekurangan dokter. Begitu pula dengan ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) prioritas di Puskesmas. Pada awalnya, hanya terdapat 1.899 Puskesmas yang dilengkapi dengan 9 jenis nakes prioritas, tetapi saat ini sudah ada 5.152 Puskesmas yang telah lengkap dengan tenaga kesehatan. Untuk tenaga 7 jenis dokter spesialis prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Daerah, jumlahnya meningkat dari 634 RSUD menjadi 664 RSUD. Tantangan dalam hal ini adalah mendorong daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, yang sering kali terkait dengan kapasitas fiskal dan komitmen daerah tersebut. Bersama Kementerian PAN-RB, Kemenkes telah melakukan pengangkatan tenaga kesehatan honorer di tahun 2022, dengan penempatan sebanyak 62.707 tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2023, sebanyak 135.000 tenaga honorer nakes direncanakan untuk ditempatkan kembali. Meskipun terdapat peningkatan dalam distribusi tenaga kesehatan, prevalensi ketidakmerataan ini tetap menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai pemerataan pelayanan kesehatan.

Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan distribusi SDM. Banyak daerah, terutama di pedesaan dan pesisir, kekurangan tenaga kesehatan yang cukup. Misalnya, di puskesmas, rasio tenaga kesehatan yang ada belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terus berkembang. Ketidakmerataan ini memperburuk kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, kurangnya jumlah SDM yang tersedia memengaruhi mutu layanan. Kekurangan tenaga kesehatan menyebabkan banyak profesional harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, padahal seharusnya mereka fokus pada spesialisasi masing-masing. Hal ini memengaruhi kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan.

Desentralisasi dalam manajemen kesehatan turut memperburuk distribusi SDM di Indonesia, mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengatur alokasi tenaga kesehatan. Wilayah terpencil menjadi yang paling terpengaruh oleh kesenjangan ini. Rekrutmen tenaga kesehatan juga menjadi tantangan besar, dengan banyak daerah kesulitan menarik tenaga medis ke wilayah mereka, terutama di daerah yang kurang diminati. Selain masalah distribusi dan jumlah, motivasi dan pelatihan juga menjadi isu penting. Banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang tidak tertarik untuk meningkatkan keterampilan mereka karena kurangnya insentif dan beban pekerjaan yang tinggi.

Kendala Infrastruktur yang Dihadapi Indonesia

Masalah infrastruktur adalah bagian dari tantangan besar dalam sistem kesehatan di Indonesia yang mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Infrastruktur yang tidak merata dan tidak memadai, baik itu fasilitas fisik seperti puskesmas, rumah sakit, maupun sarana penunjang lainnya, menghambat upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Hasil riset yang dilakukan lembaga riset *The Indonesian Institute* pada tahun 2024 mencatat bahwa masalah infrastruktur masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Dari sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada, sebagian besar fasilitas kesehatan tersebut terpusat di kota-kota besar, sementara banyak daerah yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas dan letak geografis yang sulit dijangkau.

Teori *Social Determinants of Health* (SDH) mengemukakan bahwa akses terhadap fasilitas kesehatan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Ketidakmerataan distribusi infrastruktur kesehatan di Indonesia menambah ketidaksetaraan kesehatan antarwilayah, yang sering kali mengakibatkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan (Kokkinen, 2022). Oleh karena itu, untuk mencapai sistem kesehatan yang efisien dan adil, perlu adanya

pemerataan dalam distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau.

2. Masalah Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan adalah sebuah cabang ilmu dalam ekonomi kesehatan, dan yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah jumlah dana yang perlu dialokasikan oleh individu, keluarga, atau kelompok masyarakat (Sopiani et al., 2022). Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan dari anggaran pemerintah dan masyarakat. Berikut beberapa permasalahan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia:

a. Kurangnya dana yang tersedia

Di banyak negara terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini kait berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 23% dari total anggaran belanja dalam setahun.

b. Penyebaran dana yang tidak sesuai

Masalah lain yang dihadapi adalah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan.

c. Pemanfaatan dana yang tidak tepat

Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi dari pada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif dari pada pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Pengelolaan dana yang belum sempurna

Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempurna, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, dalam batas-batas tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya

memang belum sempurna, yang kait berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola.

e. Biaya kesehatan yang makin meningkat

Biaya kesehatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk inflasi, kemajuan teknologi medis yang semakin kompleks dan mahal, serta peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan akibat pergeseran pola penyakit dan pertumbuhan populasi. Konsekuensinya, akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu menjadi semakin terbatas, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

D. Kebijakan Kesehatan Indonesia

Kebijakan kesehatan termasuk dalam ranah kebijakan publik, yang pada dasarnya mencerminkan peran negara yang kuat dengan legitimasi dan otoritas. Negara mewakili masyarakat melalui administrasi yang kompeten, penerapan teknik keuangan yang tepat, serta implementasi peraturan kebijakan yang efektif. Kebijakan merupakan hasil kesepakatan bersama terkait suatu isu, dengan tujuan dan target yang jelas serta panduan strategis untuk mencapainya (Nasution et al., 2024).

Kebijakan kesehatan merupakan elemen penting dalam sistem kesehatan yang komprehensif. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti sumber daya, struktur organisasi, pengelolaan, elemen penunjang dan layanan kesehatan (Anggriani et al., 2020). Kebijakan kesehatan bertujuan untuk merumuskan berbagai program baik di tingkat pusat maupun daerah. Program-program ini dirancang untuk mengubah faktor-faktor penentu kesehatan, termasuk kebijakan kesehatan global. Kebijakan ini mengedepankan kepentingan pengguna layanan kesehatan, serta para pengelola dan tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, kebijakan kesehatan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan berorientasi pada pelayanan kesehatan publik.

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan kesehatan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Pemerintah telah menerapkan beragam strategi untuk menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan bervariasi di seluruh nusantara. Beberapa kebijakan utama yang telah dijalankan meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), upaya pengendalian penyakit menular, dan juga penanggulangan penyakit tidak menular.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, adalah salah satu program kesehatan paling signifikan di Indonesia. Program ini, yang dimulai pada tahun 2014, bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia memiliki akses yang setara dan terjangkau ke layanan kesehatan. JKN mencakup berbagai jenis layanan, dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga rehabilitasi. Implementasinya telah membantu meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

2. Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam menangani penyakit menular, termasuk tuberkulosis (TB), malaria, dan HIV/AIDS. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contohnya adalah penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) secara nasional dalam penanggulangan TB, yang bertujuan untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan sepenuhnya untuk mencegah resistensi obat.

3. Kebijakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam menangani penyakit menular, termasuk tuberkulosis (TB), malaria, dan HIV/AIDS. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contohnya adalah penerapan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) secara nasional dalam penanggulangan TB, yang bertujuan untuk memastikan pasien menyelesaikan pengobatan sepenuhnya untuk mencegah resistensi obat.

Inovasi Kebijakan dan Program Kesehatan

Transformasi sistem kesehatan di Indonesia menjadi agenda utama, dengan berbagai inovasi kebijakan yang berupaya mengatasi disparitas dan meningkatkan mutu layanan. Transformasi ini mencakup penguatan layanan primer, peningkatan kualitas layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan (Kemenkes RI, 2024). Salah satu inovasi yang signifikan adalah pendekatan keluarga dalam pelayanan kesehatan primer, yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dasar dengan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Selain itu, pemanfaatan *telemedicine* sebagai solusi untuk mengatasi kendala geografis dalam akses layanan spesialis juga menjadi terobosan. Berbagai studi penelitian telah menunjukkan efektivitas *telemedicine* dalam meningkatkan akses layanan spesialis, terutama di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan panduan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Panduan Pemanfaatan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada tahun 2022, yang menguatkan peran telemedicine dalam sistem kesehatan nasional. Selanjutnya, inovasi kebijakan dan program kesehatan di Indonesia mencakup beberapa poin penting:

1. Pembiayaan Kesehatan

- a. Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK): Implementasi PBK dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendorong efisiensi dan kualitas layanan. Dampak positif PBK, yang didukung Petunjuk Teknis Implementasi Pembayaran Berbasis Kinerja dalam JKN.
- b. E-Katalog: Penggunaan e-katalog dalam pengadaan obat dan alat kesehatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Tata Kelola dan Digitalisasi Kesehatan

- a. Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi: Pembangunan platform data kesehatan terintegrasi untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.
- b. Surveilans Berbasis Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan penyakit menular dan kejadian luar biasa (KLB) yang lebih cepat dan responsif.

E. Kesimpulan

Sistem kesehatan mencakup layanan formal dan informal dengan empat fungsi utama yaitu pelayanan, pembiayaan, sumber daya, dan regulasi. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi ciri khas sistem kesehatan Indonesia, dengan tujuan pemerataan akses. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah komponen vital dalam sistem ini. Pembiayaan kesehatan mengandalkan dana publik dan pribadi untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan peran sentral pemerintah dalam kebijakan, infrastruktur, dan pengelolaan dana. Meskipun demikian, sistem kesehatan Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan akses dan kualitas layanan, distribusi SDM yang tidak merata, kendala infrastruktur, dan masalah pembiayaan. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan berbagai kebijakan, termasuk JKN, serta inovasi dalam pelayanan primer, telemedicine, pembayaran berbasis kinerja, digitalisasi, dan surveilans. Upaya ini didukung oleh bukti ilmiah dan regulasi. Tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan sistem kesehatan yang ideal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

F. Referensi

Addinni, T. (2023). Peranan Penting Keterlibatan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagai Subsistem Upaya Kesehatan di Indonesia. *Researchgate, December*.

- Anggriani, Y., Ramadaniati, H. U., Sarnianto, P., Pontoan, J., & Suryawati, S. (2020). The Impact of Pharmaceutical Policies on Medicine Procurement Pricing in Indonesia Under the Implementation of Indonesia's Social Health Insurance System. *Value in Health Regional Issues*, 21, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.vhri.2019.05.005>
- Hadning, I., Andayani, T. M., Endarti, D., & Triasih, R. (2021). Health-Related Quality of Life Among Children With Pneumonia in Indonesia Using the EuroQoL Descriptive System Value Set for Indonesia. *Value in Health Regional Issues*, 24, 12–16. <https://doi.org/10.1016/j.vhri.2020.05.010>
- Handayani, P. W., Dartanto, T., Moeis, F. R., Pinem, A. A., Azzahro, F., Hidayanto, A. N., Denny, & Ayuningtyas, D. (2021). The Regional And Referral Compliance Of Online Healthcare Systems By Indonesia National Health Insurance Agency And Health-Seeking Behavior In Indonesia. *Heliyon*, 7(9), e08068. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08068>
- Kemenkes RI. (2024, November). *Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Diambil kembali dari Kementrian Kesehatan RI : <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/>
- Kemenkes RI. (2024, December). *Transformasi Kesehatan Indonesia*. Diambil kembali dari Kementrian Kesehatan RI: <https://kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-kesehatan-indonesia>
- Kemenkes RI. (2025, January). *Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan*. Diambil kembali dari Kementrian Kesehatan RI: <https://kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-sistem-pembiayaan-kesehatan>
- Kemenkes RI. (22, October). *Pemerintah Jamin Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Melalui JKN*. Diambil kembali dari Kementrian Kesehatan RI : <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/pemerintah-jamin-pelayanan-kesehatan-bagi-masyarakat-melalui-jkn/>
- Kokkinen, L. (2022). Studying social determinants of health using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis: A worked example. *Social Science and Medicine*, 309(August), 115241. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115241>
- Mahendradhata, Y., Andayani, N. L. P. E., Hasri, E. T., Arifi, M. D., Siahaan, R. G. M., Solikha, D. A., & Ali, P. B. (2021). The Capacity of the Indonesian Healthcare System to Respond to COVID-19. *Frontiers in Public Health*, 9(July), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649819>
- Mahmood, M. A., Hendarto, H., Laksana, M. A. C., Damayanti, H. E., Suhargono, M. H., Pranadyan, R., Santoso, K. H., Redjeki, K. S., Winard, B., Prasetyo, B., Vercruyssen, J., Moss, J. R., Bi, P., Masitah, S., Warsiti, Pratama, A. W., Dewi,

- E. R., Listiyani, C. H., & Mufidah, I. (2021). Health system and quality of care factors contributing to maternal deaths in East Java, Indonesia. *PLoS ONE*, 16(2 February), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247911>
- Nasution, I. S., Said, N. B., Salsabila, M., Maulidia, A., Ji, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia : Tinjauan , Tantangan , dan Rekomendasi Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(3).
- Rizkianti, A., Saptarini, I., & Rachmalina, R. (2021). Perceived barriers in accessing health care and the risk of pregnancy complications in Indonesia. *International Journal of Women's Health*, 13, 761–772. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S310850>
- Sopiani, L., Ulfa, M., Zaini, Andriana, Y., Ahyani, I., Agustin, N., Hamri, Y. R., & Wardani, L. A. K. (2022). Pembiayaan Kesehatan dan Peran Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies*, 1(4), 9.
- Suprpto, S., & Karsa, P. S. (2023). *K e b i j a k a n k e s e h a t a n n a s i o n a l* (Issue July).
- Vitrano, G., & Micheli, G. J. L. (2024). National occupational safety and health systems: Exploring the underlying networks for future sustainable development. *Sustainable Futures*, 8(June), 100382. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100382>
- Widjaja, G. (2021). Impact of human resource management on health workers during pandemics COVID-19: systematic review. *International Journal of Health & Medical Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31295/ijhms.v4n1.850>

G. Glosarium

Desentralisasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk kesehatan.

DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course): Strategi pengobatan tuberkulosis (TB) di mana pasien diawasi langsung oleh petugas kesehatan saat minum obat untuk memastikan kepatuhan.

E-Katalog: Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara daring yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan.

Kuratif: Upaya kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang sudah terjadi, seperti pengobatan dan operasi.

Out-of-pocket Expenses: Pengeluaran pribadi yang dikeluarkan pasien untuk membayar layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh asuransi atau program jaminan kesehatan.

Preventif: Upaya kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Promotif: Upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan dan gaya hidup sehat.

Rehabilitatif: Upaya kesehatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pasien setelah sakit atau cedera.

Stewardship/Regulator: Fungsi dalam sistem kesehatan yang berkaitan dengan penetapan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap sistem kesehatan.

Surveilans: Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data terkait penyakit atau masalah kesehatan untuk mendeteksi dini dan merespons kejadian luar biasa.

Telemedicine: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh.

Universal Health Coverage (UHC): Jaminan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa mengalami kesulitan finansial.

CHAPTER 4

KESEHATAN IBU DAN ANAK: STRATEGI PENGURANGAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK

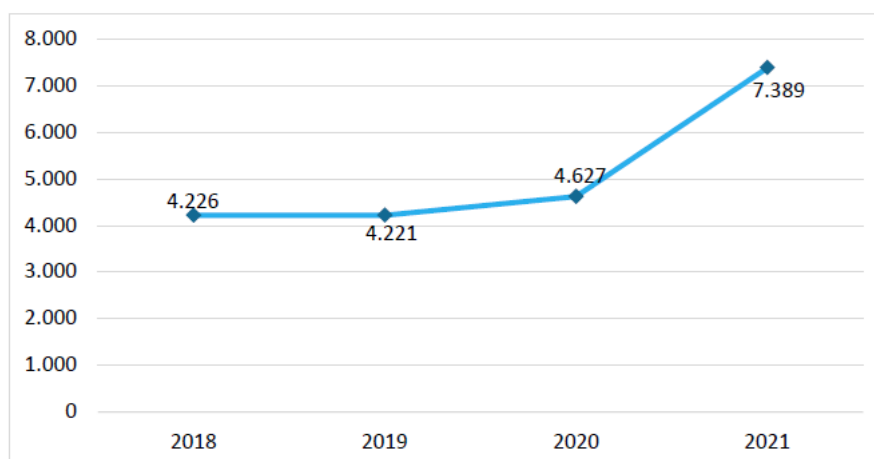
Musliha Mustary, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas sistem kesehatan suatu negara. Keberhasilan dalam menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bayi dan anak. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan ibu yang optimal dapat menurunkan risiko komplikasi persalinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (WHO, 2020). Selain itu, kesehatan anak yang terjamin sejak masa neonatal hingga usia balita menjadi fondasi utama bagi perkembangan fisik dan kognitif di masa depan (*United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2023). Oleh karena itu, memastikan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi ibu dan anak merupakan langkah fundamental dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan WHO (2022), sekitar 287.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan setiap tahunnya, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara-negara dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Di Indonesia, AKI pada tahun 2020 tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB berada pada angka 23 per 1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka ini meliputi keterbatasan akses layanan kesehatan, rendahnya kesadaran akan pentingnya perawatan prenatal, serta kepercayaan, sikap dan preferensi, dan hambatan yang berkaitan dengan struktur dan kekuasaan keluarga (Sarikhani et al., 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.

**JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2018 – 2021**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Gambar 4.1 Angka Kematian Ibu di Indonesia

**JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR
DI INDONESIA TAHUN 2021**



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Gambar 4.2 Angka Kematian Ibu di Indonesia

Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya AKI dan AKB, baik dari aspek medis maupun sosial ekonomi. Dari sisi medis, komplikasi seperti perdarahan postpartum, eklampsia, dan infeksi maternal merupakan penyebab utama kematian ibu (Alkema et al., 2016). Sementara itu, pada bayi, kematian neonatal sering kali disebabkan oleh asfiksia lahir, prematuritas, serta kelainan bawaan (Tembo et al., 2024). Selain faktor biologis, determinan sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan ibu yang rendah, praktik-praktik adat dan kepercayaan, rendahnya kesejahteraan rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap tenaga kesehatan profesional turut memperburuk kondisi ini (Moujahid et al., 2024). Oleh karena itu, upaya pengurangan AKI dan AKB harus mencakup pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek medis, kebijakan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan strategi pengurangan angka kematian ibu dan anak menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030, yang menargetkan penurunan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup. Pendekatan yang berbasis pada peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi teknologi kesehatan diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya strategi yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dapat terus menurun secara signifikan. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini akan menguraikan berbagai faktor risiko serta strategi efektif dalam menekan angka kematian ibu dan anak berdasarkan kajian ilmiah dan praktik terbaik di berbagai negara (Wenang et al., 2024).

B. Faktor Risiko Angka Kematian Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu negara. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sering kali disebabkan oleh berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, proses persalinan, serta kondisi bayi setelah lahir. Faktor-faktor ini tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga mencakup determinan sosial yang berpengaruh terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh ibu dan anak.

1. Faktor Risiko pada Ibu Hamil dan Bersalin

a. Komplikasi Kehamilan (Preeklamsia, Perdarahan Postpartum, Infeksi)

Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu yang ditandai dengan hipertensi dalam kehamilan disertai dengan proteinuria. Kondisi ini dapat berkembang menjadi eklampsia, yang berisiko menyebabkan kejang dan kematian maternal jika tidak ditangani dengan cepat (Mustary et al., 2024). Selain itu, perdarahan postpartum merupakan penyebab kematian ibu yang paling umum, terutama di negara berkembang, akibat kurangnya penanganan segera serta ketersediaan darah untuk transfusi (Yakupu et al., 2022). Infeksi pascapersalinan juga menjadi faktor signifikan yang dapat memperburuk kondisi ibu, terutama pada persalinan yang tidak steril dan minim perawatan kesehatan (Chen et al., 2021).

b. Persalinan Tidak Aman dan Komplikasi Persalinan

Persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan profesional meningkatkan risiko komplikasi yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Banyak ibu di daerah terpencil masih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun bayi yang belum terlatih secara medis, sehingga meningkatkan risiko

infeksi, perdarahan, atau ruptur uterus (Garces et al., 2019) . Selain itu, komplikasi persalinan sering kali tidak dapat ditangani dengan baik di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki peralatan memadai ((Souza et al., 2024).

c. Gizi Ibu Hamil dan Anemia dalam Kehamilan

Kondisi gizi ibu selama kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, meningkatkan risiko perdarahan, anemia, preeklamsia, serta berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi (Detlefs et al., 2022). Anemia dalam kehamilan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu karena dapat menyebabkan hipoksia pada organ vital dan meningkatkan risiko perdarahan postpartum (Edelson et al., 2023). Oleh karena itu, pemberian suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan menjadi langkah penting dalam menurunkan risiko komplikasi kehamilan.

d. Kurangnya Akses ke Layanan Kesehatan Maternal

Akses terbatas terhadap layanan kesehatan maternal, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, serta ketimpangan pemanfaatannya di wilayah perkotaan menjadi faktor utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, kendala ekonomi, serta faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, status sosial ekonomi rendah, dan tabu budaya sering kali menghambat ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan antenatal (ANC) secara rutin. Selain itu, tinggal di daerah kumuh dengan integrasi dan dukungan sosial yang rendah semakin memperburuk kondisi ini, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi (Sidze et al., 2022).

2. Faktor Risiko pada Bayi dan Anak

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Prematuritas

BBLR dan kelahiran prematur merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya AKB. Bayi dengan berat lahir rendah (<2500 gram) lebih rentan terhadap infeksi, gangguan pernapasan, serta masalah perkembangan jangka panjang. Prematuritas juga sering dikaitkan dengan gangguan pernapasan seperti sindrom gangguan pernapasan neonatal, yang dapat meningkatkan risiko kematian neonatal (Crump, 2020) . Oleh karena itu, perawatan kehamilan yang optimal dan gizi ibu yang baik sangat penting dalam mencegah kelahiran prematur dan BBLR.

b. Infeksi Neonatal dan Penyakit Pernapasan

Infeksi neonatal, seperti sepsis dan pneumonia, merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir, terutama di negara dengan akses terbatas terhadap

fasilitas kesehatan yang memadai. Bakteri dan virus umumnya bertanggung jawab, sementara organisme jamur terjadi dalam konteks penyakit nosokomial, meningkatkan risiko kematian neonatal akibat sepsis (Green & Kolberg, 2016). Selain itu, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk pneumonia, menjadi penyebab utama kematian anak balita. Sekitar 6,6 juta anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahun di dunia; 95% di antaranya di negara berpenghasilan rendah dan sepertiga dari total kematian tersebut disebabkan oleh ISPA (Tazinya et al., 2018)

c. Malnutrisi pada Anak

Gizi yang buruk pada anak merupakan faktor risiko yang signifikan dalam meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan kematian. Stunting, yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis, berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak-anak dengan status gizi buruk lebih rentan terhadap infeksi karena sistem imun mereka yang lemah, sehingga meningkatkan angka kematian anak balita (Walson & Berkley, 2018).

d. Kurangnya Cakupan Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah kematian bayi dan anak akibat penyakit menular. Namun, cakupan imunisasi yang rendah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah konflik, meningkatkan risiko wabah penyakit seperti campak, pertusis, dan polio. (WHO, 2019). Program imunisasi yang tidak merata menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Imunisasi melalui vaksin pada anak-anak telah berkontribusi pada peningkatan kelangsungan hidup dan hasil kesehatan anak secara global. Namun, cakupan vaksin di antara anak-anak tidak terdistribusi secara merata di berbagai tempat dan populasi (Lyons et al., 2024).

3. Determinasi Sosial Kesehatan

a. Kemiskinan dan Akses terhadap Fasilitas Kesehatan

Kemiskinan merupakan determinan utama yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Keluarga dengan status ekonomi rendah sering kali kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas karena keterbatasan finansial, biaya transportasi, serta kurangnya fasilitas kesehatan di daerah mereka (Chung et al., 2016).

b. Pendidikan Ibu dan Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi

Tingkat pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, serta perawatan bayi yang optimal. Ibu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki

pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi, yang berdampak pada keputusan mereka dalam mengakses layanan kesehatan (H. Wang et al., 2021).

c. Status Gizi dan Kebiasaan Pola Hidup Sehat

Gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Kebiasaan hidup sehat, termasuk konsumsi makanan bergizi, pola istirahat yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur, dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kesehatan bayi yang dikandung (Chabanova et al., 2017)

d. Faktor Budaya dan Kepercayaan dalam Kesehatan Ibu dan Anak

Dalam beberapa komunitas, masih terdapat kepercayaan tradisional yang menghambat akses ibu terhadap layanan kesehatan modern. Misalnya, pijat, kondisi polusi setelah melahirkan, penggunaan dukun dan obat tradisional serta ramuan tradisional, kepercayaan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan panas/dingin, tabu perilaku, sihir, dan takhayul (Withers et al., 2018).

C. Strategi Pengurangan Angka Kematian Ibu dan Anak

Pengurangan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah. Strategi utama dalam upaya ini mencakup peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, optimalisasi gizi ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan program kesehatan berbasis masyarakat. Intervensi yang efektif dalam setiap aspek ini dapat membantu menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa neonatal, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak secara keseluruhan.

1. Pendekatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan langkah pertama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Perawatan antenatal adalah perawatan yang diberikan kepada ibu sejak masa pembuahan hingga kelahiran anak. Aspek inti dari perawatan antenatal adalah penilaian dan pemeriksaan antenatal selama kehamilan. Ini adalah alat yang relevan untuk mengetahui kualitas perawatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilan oleh tenaga kesehatan. Ini adalah prediktor yang kuat untuk hasil maternal dan neonatal (D'Souza et al., 2023).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih juga menjadi faktor utama dalam menurunkan AKI dan AKB. Persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter spesialis kandungan di fasilitas kesehatan yang memadai dapat

mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi maternal, serta asfiksia neonatal (D'Souza et al., 2023). Keberadaan tenaga medis yang terlatih juga memastikan bahwa setiap komplikasi yang terjadi selama persalinan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Setelah persalinan, peningkatan layanan pasca persalinan dan neonatal sangat penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi. Pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan membantu mencegah komplikasi seperti infeksi postpartum dan perdarahan sekunder (Clarke-Deelder et al., 2023). Sementara itu, bayi baru lahir memerlukan perawatan yang intensif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan awal mereka, terutama dalam hal pemberian ASI eksklusif dan perawatan tali pusat yang steril (X. Wang et al., 2022).

Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan maternal dan neonatal menjadi faktor krusial dalam menangani kasus-kasus berisiko tinggi. Rumah sakit dengan fasilitas unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan peralatan medis yang memadai sangat penting bagi bayi prematur atau yang mengalami komplikasi saat lahir. Di daerah terpencil, sistem rujukan yang cepat dan efektif harus dikembangkan agar ibu dan bayi yang mengalami komplikasi dapat segera mendapatkan perawatan yang optimal (Akkoyun & Tas Arslan, 2019).

2. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Gizi yang baik selama kehamilan dan masa kanak-kanak sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Program suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil telah terbukti mengurangi risiko anemia maternal dan meningkatkan kesehatan janin. Kekurangan zat besi selama kehamilan dikaitkan dengan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), serta perdarahan postpartum (Faysal et al., 2023). Oleh karena itu, pemberian suplemen zat besi dan asam folat secara rutin harus menjadi bagian dari program kesehatan ibu hamil.

Selanjutnya, pencegahan stunting pada anak sejak 1000 hari pertama kehidupan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesehatan anak di masa depan. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan kognitif anak, yang berpengaruh terhadap produktivitas mereka di masa dewasa (UNICEF, 2023). Intervensi gizi yang tepat, termasuk pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan bayi, dapat membantu menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia (Hadju et al., 2020)/

Program ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang berkualitas juga sangat penting dalam menunjang tumbuh kembang anak. ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan memberikan nutrisi yang optimal dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, sementara pemberian makanan pendamping ASI

(MPASI) yang bergizi setelah usia enam bulan memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (Mphasha et al., 2023).

3. Peningkatan Cakupan Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Infeksi

Imunisasi merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi angka kematian bayi dan anak. Imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan balita dapat melindungi mereka dari berbagai penyakit yang berpotensi fatal seperti campak, difteri, pertusis, polio, dan hepatitis B (WHO, 2023). Namun, cakupan imunisasi di beberapa daerah masih rendah akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat (UNICEF, 2023).

Selain imunisasi, pencegahan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare pada anak juga menjadi prioritas dalam menurunkan AKB. ISPA, terutama pneumonia, merupakan penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun, sementara diare yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi berat dan malnutrisi (Bernard & Nicholson, 2021). Oleh karena itu, intervensi seperti peningkatan kebersihan, pemberian oralit, serta edukasi tentang pola makan sehat sangat penting dalam mencegah kedua penyakit ini.

Selain itu, program pencegahan dan penanggulangan malaria pada ibu hamil harus diperkuat, terutama di daerah endemis malaria. Malaria dalam kehamilan dapat menyebabkan anemia, keguguran, kelahiran prematur, serta BBLR. Penggunaan kelambu berinsektisida dan pemberian obat antimalaria yang aman bagi ibu hamil merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi dampak buruk malaria pada kehamilan (Saito et al., 2020).

4. Program Kesehatan Berbasis Masyarakat

Program kesehatan berbasis masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Peran Posyandu dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak sangat penting dalam mendeteksi dini masalah kesehatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perawatan kehamilan dan imunisasi. Selain itu, kader kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam edukasi KIA dapat membantu meningkatkan kesadaran ibu hamil dan keluarga tentang kesehatan maternal dan neonatal (Mardiyanti & Wibowo, 2018). Dengan adanya kader kesehatan yang aktif, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang pola makan sehat, tanda bahaya kehamilan, serta pentingnya persalinan di fasilitas medis.

Untuk daerah terpencil, program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) menjadi solusi efektif dalam mengurangi risiko komplikasi kehamilan. RTK memungkinkan ibu hamil yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan untuk tinggal sementara di lokasi yang dekat dengan rumah sakit atau puskesmas menjelang persalinan,

sehingga dapat segera mendapatkan pertolongan medis saat dibutuhkan (Zuanna et al., 2021).

Terakhir, peran bidan desa dan dukun bayi dalam perawatan maternal dan neonatal juga perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan tenaga medis. Kolaborasi antara tenaga kesehatan profesional dengan tenaga nonmedis yang telah dikenal oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan ibu dalam menerima layanan kesehatan yang lebih modern dan berbasis bukti ilmiah (Usman, 2019).

D. Kebijakan dan Intervensi Pemerintah

Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, memiliki peran penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak melalui kebijakan serta program yang terstruktur. Target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menargetkan angka kematian ibu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang memberikan akses persalinan gratis bagi ibu hamil yang kurang mampu (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, keberadaan BPJS Kesehatan memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan finansial yang signifikan. Pemerintah juga terus mengembangkan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk standar pelayanan minimal (SPM) dalam kesehatan maternal dan neonatal guna memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia (KEMENKES RI, 2016).

Seiring dengan kemajuan teknologi, strategi digital dan inovasi mulai diterapkan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu inovasi yang berkembang adalah telemedicine, yang memungkinkan ibu hamil mendapatkan konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan (Healy et al., 2023). Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap tenaga medis. Selain itu, berbagai aplikasi mobile telah dikembangkan untuk membantu ibu hamil memantau kesehatan mereka dan bayi mereka, seperti aplikasi pencatatan jadwal pemeriksaan kehamilan, edukasi seputar kehamilan dan persalinan, serta pengingat untuk imunisasi anak (Renhoran et al., 2023). Pemerintah juga mulai mengimplementasikan sistem pencatatan elektronik dalam KIA, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data kesehatan ibu dan anak serta mempermudah koordinasi antar tenaga medis dalam memberikan layanan.

Evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah diterapkan menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, yang menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan antara perkotaan dan pedesaan. Selain itu, meskipun kebijakan seperti Jampersal dan BPJS Kesehatan telah membantu banyak ibu hamil dalam mendapatkan layanan kesehatan, masih terdapat kendala administratif yang menghambat akses yang optimal. Edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan dan imunisasi bayi juga masih perlu ditingkatkan, terutama di komunitas dengan kepercayaan tradisional yang kurang mendukung layanan kesehatan modern (Omer et al., 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan ibu dan anak, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, diperlukan peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil serta penyediaan tenaga medis yang memadai agar pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dapat menjangkau seluruh masyarakat (Ali et al., 2024). Kedua, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan harus diperluas, termasuk dengan memperbaiki sistem pencatatan elektronik dan memperluas jangkauan telemedicine bagi ibu hamil (Revathy & Mangaiyarkkarasi, 2023). Ketiga, edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan ibu dan anak perlu lebih digencarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan program berbasis komunitas seperti Posyandu dan kader kesehatan (UNICEF, 2023). Dengan strategi yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan angka kematian ibu dan anak dapat terus menurun sehingga kesehatan generasi mendatang dapat terjamin dengan lebih baik.

E. Referensi

- Akkoyun, S., & Tas Arslan, F. (2019). Investigation of stress and nursing support in mothers of preterm infants in neonatal intensive care units. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 33(2), 351–358. Scopus. <https://doi.org/10.1111/scs.12630>
- Ali, A. A., Naseem, H. A., Allahuddin, Z., Yasin, R., Azhar, M., Hanif, S., Das, J. K., & Bhutta, Z. A. (2024). The Effectiveness of Regionalization of Perinatal Care and Specific Facility-Based Interventions: A Systematic Review. *Neonatology*. Scopus. <https://doi.org/10.1159/000541384>
- Alkema, L., Chou, D., Hogan, D., Zhang, S., Moller, A.-B., Gemmill, A., Fat, D. M., Boerma, T., Temmerman, M., Mathers, C., & Say, L. (2016). Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: A systematic analysis by the UN

- Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. *The Lancet*, 387(10017), 462–474. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00838-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00838-7)
- Bernard, R., & Nicholson, M. (2021). Bacterial Infections of the Small and Large Intestine. In *Textbook of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: A Comprehensive Guide to Practice: Second Edition* (pp. 203–218). Springer International Publishing; Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80068-0_15
- Chabanova, N. B., Ataev, S. I., Vasilkova, T. N., Shevlyukova, T. P., & Troshina, I. A. (2017). The role of a nutritional factor in the development of obstetric and perinatal pathology in obese women. *Voprosy Pitaniia*, 86(4), 6–21. Scopus.
- Chen, L., Wang, Q., Gao, Y., Zhang, J., Cheng, S., Chen, H., Zeng, Z., & Wang, Z. (2021). The global burden and trends of maternal sepsis and other maternal infections in 204 countries and territories from 1990 to 2019. *BMC Infectious Diseases*, 21(1), 1074. <https://doi.org/10.1186/s12879-021-06779-0>
- Chung, E. K., Siegel, B. S., Garg, A., Conroy, K., Gross, R. S., Long, D. A., Lewis, G., Osman, C. J., Jo Messito, M., Wade, R., Shonna Yin, H., Cox, J., & Fierman, A. H. (2016). Screening for Social Determinants of Health among Children and Families Living in Poverty: A Guide for Clinicians. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, 46(5), 135–153. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2016.02.004>
- Clarke-Deelder, E., Opondo, K., Oguttu, M., Burke, T., Cohen, J. L., & McConnell, M. (2023). Immediate postpartum care in low- and middle-income countries: A gap in healthcare quality research and practice. *American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM*, 5(2). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100764>
- Crump, C. (2020). Preterm birth and mortality in adulthood: A systematic review. *Journal of Perinatology*, 40(6), 833–843. <https://doi.org/10.1038/s41372-019-0563-y>
- Detlefs, S. E., Jochum, M. D., Salmanian, B., McKinney, J. R., & Aagaard, K. M. (2022). The impact of response to iron therapy on maternal and neonatal outcomes among pregnant women with anemia. *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*, 4(2), 100569. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100569>
- D'Souza, P., Frank, R. W., D'Almeida, J. D., & Maheshwari, S. K. (2023). Newer Concept of Antenatal Care and Antenatal Examination/Assessment. In *Labour and Delivery: An Updated Guide* (pp. 135–158). Springer Nature; Scopus. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6145-8_10
- Edelson, P. K., Cao, D., James, K. E., Ngonzi, J., Roberts, D. J., Bebell, L. M., & Boatin, A. A. (2023). Maternal anemia is associated with adverse maternal and neonatal outcomes in Mbarara, Uganda. *The Journal of Maternal-Fetal &*

- Faysal, H., Araj, T., & Ahmadzia, H. K. (2023). Recognizing who is at risk for postpartum hemorrhage: Targeting anemic women and scoring systems for clinical use. *American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM*, 5(2). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2022.100745>
- Garces, A., McClure, E. M., Espinoza, L., Saleem, S., Figueroa, L., Bucher, S., & Goldenberg, R. L. (2019). Traditional birth attendants and birth outcomes in low-middle income countries: A review. *Seminars in Perinatology*, 43(5), 247–251. <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2019.03.013>
- Green, R. J., & Kolberg, J. M. (2016). Neonatal pneumonia in sub-Saharan Africa. *Pneumonia*, 8(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s41479-016-0003-0>
- Hadju, V., Dassir, M., Sadapotto, A., Putranto, A., Marks, G., & Arundhana, A. I. (2020). Effects of moringa oleifera leaves and honey supplementation during pregnancy on mothers and newborns: A review of the current evidence. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8, 208–214. Scopus. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.4670>
- Healy, A., Davidson, C., Allbert, J., Bauer, S., Toner, L., & Combs, C. A. (2023). Society for Maternal-Fetal Medicine Special Statement: Telemedicine in obstetrics—Quality and safety considerations. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 228(3), B8–B17. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.12.002>
- KEMENKES RI. (2016). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN*.
- Lyons, C., Nambiar, D., Johns, N. E., Allorant, A., Bergen, N., & Hosseinpour, A. R. (2024). Inequality in Childhood Immunization Coverage: A Scoping Review of Data Sources, Analyses, and Reporting Methods. *Vaccines*, 12(8), 850. <https://doi.org/10.3390/vaccines12080850>
- Mardiyanti, I., & Wibowo, A. (2018). Implementation of birth preparedness and complication readiness (BPCR) in high risk pregnancies. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(11), 1739–1744. Scopus. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.01695.9>
- Moujahid, C., Turman, J. E., & Amahdar, L. (2024). A scoping review of the social determinants of maternal health in the MENA region. *The Pan African Medical Journal*, 47. <https://doi.org/10.11604/pamj.2024.47.205.42499>
- Mphasha, M. H., Makwela, M. S., Muleka, N., Maanaso, B., & Phoku, M. M. (2023). Breastfeeding and Complementary Feeding Practices among Caregivers at Seshego Zone 4 Clinic in Limpopo Province, South Africa. *Children*, 10(6). Scopus. <https://doi.org/10.3390/children10060986>

- Mustary, M., Syam, A., Riskiyani, S., Erika, K. A., Moedjiono, A. I., & Lubis, M. (2024). Preeclampsia: Etiology, Pathophysiology, Risk Factors, Impact and Prevention: A Narrative Review. *Iranian Journal of Public Health*, 53(11), 2392–2403. Scopus.
- Omer, S., Zakar, R., Zakar, M. Z., & Fischer, F. (2021). The influence of social and cultural practices on maternal mortality: A qualitative study from South Punjab, Pakistan. *Reproductive Health*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01151-6>
- Renhoran, A. M., Alibasa, M. J., Nuha, H. H., & Bawono, M. W. A. (2023). Development of a Monitoring and Guidance Android Application for Pregnant Women. *Int. Conf. Intell. Cybern. Technol. Appl., ICICyTA*, 34–38. Scopus. <https://doi.org/10.1109/ICICyTA60173.2023.10428727>
- Revathy, J. S., & Mangaiyarkkarasi, J. (2023). Pregnancy in the digital age: A new era of healthcare technologies. In *Predict. Pregnancy Complicat. Through Artif. Intell. And Mach. Learn.* (pp. 293–309). IGI Global; Scopus. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8974-1.ch019>
- Saito, M., Briand, V., Min, A. M., & McGready, R. (2020). Deleterious effects of malaria in pregnancy on the developing fetus: A review on prevention and treatment with antimalarial drugs. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(10), 761–774. Scopus. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30099-7](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30099-7)
- Sarikhani, Y., Najibi, S. M., & Razavi, Z. (2024). Key barriers to the provision and utilization of maternal health services in low-and lower-middle-income countries; a scoping review. *BMC Women's Health*, 24(1), 325. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03177-x>
- Sidze, E. M., Wekesah, F. M., Kisia, L., & Abajobir, A. (2022). Inequalities in Access and Utilization of Maternal, Newborn and Child Health Services in sub-Saharan Africa: A Special Focus on Urban Settings. *Maternal and Child Health Journal*, 26(2), 250–279. <https://doi.org/10.1007/s10995-021-03250-z>
- Souza, J. P., Day, L. T., Rezende-Gomes, A. C., Zhang, J., Mori, R., Baguiya, A., Jayaratne, K., Osoti, A., Vogel, J. P., Campbell, O., Mugerwa, K. Y., Lumbiganon, P., Tunçalp, Ö., Cresswell, J., Say, L., Moran, A. C., & Oladapo, O. T. (2024). A global analysis of the determinants of maternal health and transitions in maternal mortality. *The Lancet Global Health*, 12(2), e306–e316. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00468-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00468-0)
- Tazinya, A. A., Halle-Ekane, G. E., Mbuagbaw, L. T., Abanda, M., Atashili, J., & Obama, M. T. (2018). Risk factors for acute respiratory infections in children under five years attending the Bamenda Regional Hospital in Cameroon. *BMC Pulmonary Medicine*, 18(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s12890-018-0579-7>
- Tembo, D., Abobo, F. D. N., Kaonga, P., Jacobs, C., & Bessing, B. (2024). Risk factors associated with neonatal mortality among neonates admitted to neonatal

- intensive care unit of the University Teaching Hospital in Lusaka. *Scientific Reports*, 14(1), 5231. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56020-6>
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023*. <https://data.unicef.org/resources/sowc-2023/>
- Usman, S. (2019). Creating Synergy between Village Midwives and Traditional Midwives: To Reduce the Mortality Rate of Mothers and Babies: In the Central Kluet Sub-District Health Centre in South Aceh. In Rahim R., Ahmar A.S., & Hidayat R. (Eds.), *J. Phys. Conf. Ser.* (Vol. 1232, Issue 1). Institute of Physics Publishing; Scopus. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1232/1/012051>
- Walson, J. L., & Berkley, J. A. (2018). The impact of malnutrition on childhood infections. *Current Opinion in Infectious Diseases*, 31(3), 231–236. <https://doi.org/10.1097/QCO.0000000000000448>
- Wang, H., Frasco, E., Takesue, R., & Tang, K. (2021). Maternal education level and maternal healthcare utilization in the Democratic Republic of the Congo: An analysis of the multiple indicator cluster survey 2017/18. *BMC Health Services Research*, 21(1). Scopus. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06854-x>
- Wang, X., Zhang, X., Sobel, H. L., Li, Z., Juan, J., & Yang, H. (2022). Early essential newborn care for cesarean section newborns in China: Study protocol for a multi-centered randomized controlled trial. *Trials*, 23(1). Scopus. <https://doi.org/10.1186/s13063-022-06615-z>
- Wenang, S., Febrianti, L., Hilman, O., Nd, P. E., Nababan, F., & Sugiyo, D. (2024). *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN MATERNAL AND CHILD HEALTH: KNOWLEDGE, PERCEPTION AND EXPERIENCES OF THE POOREST HOUSEHOLDS*. 24.
- WHO. (2020). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience: Nutritional interventions update: multiple micronutrient supplements during pregnancy*. Human Reproduction Programme, World Health Organization.
- WHO, W. H. O. (2019). *Vaccines and immunization*. https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
- Withers, M., Kharazmi, N., & Lim, E. (2018). Traditional beliefs and practices in pregnancy, childbirth and postpartum: A review of the evidence from Asian countries. *Midwifery*, 56, 158–170. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.10.019>
- Yakupu, A., Wang, H., Huang, L., Zhou, J., Wu, F., Lu, Y., & Lu, S. (2022). Global, Regional, and National Levels and Trends in the Burden of Pressure Ulcer from 1990 to 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease

2019. *International Journal of Lower Extremity Wounds*. Scopus. <https://doi.org/10.1177/15347346221092265>

Zuanna, T. D., Fonzo, M., Sperotto, M., Resti, C., Tsegaye, A., Azzimonti, G., Manenti, F., Putoto, G., & Bertoncello, C. (2021). The effectiveness of maternity waiting homes in reducing perinatal mortality: A case-control study in Ethiopia. *BMJ Global Health*, 6(4). Scopus. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004140>

CHAPTER 5

KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT, STRATEGI PENGURANGAN STIGMA, DAN PENINGKATAN ASKSES LAYANAN

Dr. Cucu Herawati, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Hak untuk kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Hak ini mencakup kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari definisi kesehatan, dan memiliki peran yang cukup penting untuk memaksimalkan kesehatan setiap individu. Kondisi mental yang sehat tidak sama untuk semua orang namun, memilikinya memungkinkan seseorang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan normal, bekerja dengan produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Kesehatan mental mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat (Kusumaningsih, 2023).

Kesehatan mental mengacu pada kesehatan keseluruhan seseorang selama perkembangan, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental tidak sama untuk semua orang dan berubah seiring perkembangan. Karena manusia selalu menghadapi situasi di mana mereka memiliki opsi untuk menyelesaikan masalah mereka. Kesehatan mental adalah komponen penting dari kesehatan secara keseluruhan (Ghefira et al., 2023). Kesehatan mental yang baik membantu orang melihat potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan, menjadi produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka (Nur Haryanti et al., 2024).

Kecemasan berdampak pada kesehatan mental anak-anak dan remaja karena tuntutan pola kehidupan yang semakin berubah yang menuntut orang untuk berpikir secara instan dan membutuhkan profesional untuk melakukan berbagai hal. Salah satu komponen yang memengaruhi kesehatan mental masyarakat adalah kecemasan (Ariadi, 2019).

Banyak hal yang memengaruhi kesehatan mental, seperti interaksi sosial, psikologis, unsur biologis, ekonomi, lingkungan, dan perilaku. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya kesehatan mental harus mencakup bidang yang lebih luas daripada kesehatan semata-mata (Nur Haryanti et al., 2024). Gangguan kesehatan mental adalah penyakit psikologis yang disebabkan oleh ketidakmampuan

seseorang untuk mengatasi masalah hidup mereka. Kesehatan fisik dan produktivitas dapat dipengaruhi oleh kesehatan mental. Kesehatan dan produktivitas dapat ditingkatkan dengan gaya hidup sehat. Di Indonesia, upaya penanganan kesehatan mental harus mencakup bidang yang lebih luas daripada hanya bidang Kesehatan (Aurel Sulthon Hakim; Aji Mulyana; Mia Amalia, 2024).

Pemerintah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai dan optimal ke layanan kesehatan yang layak (Kusumaningsih, 2023). Masyarakat Indonesia juga harus menghadapi ancaman gangguan kesehatan mental yang merajalela di seluruh dunia. Pemerintah harus memulai dengan melakukan riset yang komperhensif untuk memotret kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia. Tanpa data epidemiologis yang berkualitas, tentunya tidak mungkin untuk membuat kebijakan kesehatan mental yang berdasarkan bukti. Sangat mungkin untuk mengatur program program kunci dan alokasi anggaran secara proporsional dengan data yang komperhensif (Kusumaningsih, 2023).

B. Epidemiologi Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental tidak bisa kita remehkan, karena jumlah kasusnya saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Diperkirakan sekitar 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan mental, dan sekitar 25% dari mereka akan mengalami gangguan mental sepanjang hidup mereka. Di India, WHO melaporkan jumlah kasus gangguan depresi tertinggi, 4,5% dari populasi. Di Indonesia, jumlah kasus ini adalah 9.162.886 kasus, atau 3,7% dari populasi (Nur Haryanti et al., 2024). Data WHO tahun 2019 menunjukkan bahwa 264 juta orang menderita depresi, 45 juta menderita gangguan bipolar, 50 juta menderita demensia, 20 juta orang menderita skizofrenia, dan skizofrenia adalah salah satu dari 15 penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan memiliki risiko bunuh diri yang tinggi (Ghefira et al., 2023). Menurut WHO, gangguan mental emosional menempati 16% dari semua beban penyakit, dan setengah dari semua kasus dimulai pada usia 14 tahun. Banyak faktor menyebabkan gangguan mental tidak terdeteksi atau diobati, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang kesehatan mental di kalangan petugas kesehatan dan Masyarakat (Ariadi, 2019).

Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi gangguan jiwa berat sebesar 1,7‰ atau 1.728 orang, menurun dari data tahun 2007 sebesar 4,6‰. Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah (11,6%), Sulawesi Selatan (9,3%), dan Jawa Barat (9,3%), sedangkan Provinsi Lampung memiliki prevalensi terendah sekitar 1,2% (Nur Haryanti et al., 2024).

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi depresi, gangguan emosi, dan gangguan mental berat di Indonesia berada pada taraf mengkhawatirkan (Winurini, 2023). 14% keluarga melakukan kurungan dalam 3 bulan terakhir (Aurel Sulthon Hakim; Aji Mulyana; Mia Amalia, 2024).

Hasil penelitian Departemen Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi, sebagai berikut: gangguan kecemasan adalah 5,7%, depresi adalah 3,7%, skizofrenia adalah 1%, gangguan bipolar adalah 0,7-1,5%, dan gangguan obsesif-kompulsif adalah 2,5-3% (Ghefira et al., 2023). Dalam survei online yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 4.010 orang, 71% perempuan dan 29% laki-laki, ditemukan bahwa 64,8% responden mengalami masalah mental, 61,5% mengalami depresi, dan 74,8% mengalami trauma (Ariadi, 2019).

C. Kesehatan Mental Masyarakat

1. Konsep Kesehatan Mental

Kesehatan mental berasal dari bahasa Inggris, yaitu mental hygiene. Mental berasal dari kata latin mens, mentis yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Sedangkan hygiene berasal dari kata Yunani hygiene yang berarti ilmu tentang Kesehatan. Kesehatan mental merupakan perkembangan fisik, intelektual, emosional seseorang, berkembang pada kehidupannya, tanggung jawab, menemukan penyesuaian, memelihara aturan sosial, dan tindakan dalam budayanya. Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan (well-being) seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada Masyarakat (Ardiansyah et al., 2023).

Menurut Abdul Hamid (2017), Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun, akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Kesehatan mental Agung Rai (2016), adalah orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah, adanya keserasian fungsi jiwa, merasa berharga, berguna, dan berbahagia serta dapat menggunakan potensi yang ada semaksimal mungkin (Handayani, 2022).

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan

kontribusi untuk komunitasnya (Nur Haryanti et al., 2024). Semua aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis, disebut kesehatan mental. Kesehatan mental meliputi bagaimana mengatasi stres, kesulitan menyesuaikan diri, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan. Kesehatan mental setiap orang unik dan berubah seiring perkembangan mereka, karena pada dasarnya manusia dihadapkan pada kondisi yang harus mereka selesaikan dengan berbagai cara (Fakhriyani, 2019).

2. Karakteristik Kesehatan Mental

Menurut WHO, Karakteristik mental yang sehat adalah sebagai berikut (Fakhriyani, 2019):

- a. Mampu belajar sesuatu dari pengalaman
- b. Mampu beradaptasi
- c. Lebih senang memberi daripada menerima
- d. Lebih cenderung membantu daripada dibantu
- e. Memiliki rasa kasih sayang
- f. Memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya
- g. Menerima kekecewaan kegagalan sebagai pengalaman
- h. Selalu berpikir positif (positive thinking).

Ciri kejiwaan yang sehat menurut Sikun (Yusuf 2011), yakni:

- a. Memiliki perasaan aman, yang terbebas dari rasa cemas.
- b. Memiliki harga diri yang mantap.
- c. Spontanitas dalam kehidupan dengan memiliki emosi yang hangat & terbuka.
- d. Memiliki keinginan-keinginan duniawi yang wajar sekaligus seimbang, dalam artian mampu memuaskannya secara positif dan wajar pula.
- e. Mampu belajar mengalah dan merendahkan diri sederajat dengan orang lain.
- f. Tahu diri, yakni mampu menilai kekuatan dan kekurangan dirinya baik dari segi fisik maupun psikis, secara tepat dan obyektif.
- g. Mampu memandang fakta sebagai realitas dengan memperlakukannya sebagaimana mestinya.
- h. Toleransi terhadap ketegangan atau stres, artinya tidak panik saat menghadapi masalah sehingga tetap positif antara fisik, psikis, dan sosial
- i. Memiliki integrasi dan kemantapan dalam kepribadiannya.
- j. Mempunyai tujuan hidup yang adekuat.
- k. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman.

3. Fungsi Kesehatan Mental

Kesehatan mental berfungsi untuk memelihara dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat, serta terhindar dari mental illness. Fungsi kesehatan mental sebagai berikut: (Diana Vidya : 2019)

a. Prevention (pencegahan)

Kesehatan mental membantu orang menghindari masalah atau gangguan mental. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesehatan mental. Menjaga kesehatan fisik dan memenuhi kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, dan aktualisasi diri adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang memaksimalkan potensinya.

b. Amelioration (kuratif/perbaikan)

Perbaikan diri adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selain itu, orang dapat mengontrol perilaku dan mekanisme pertahanan diri mereka sendiri.

c. Preservation (preservasi/pengembangan)

Fungsi pengembangan yang dikenal sebagai perlindungan atau supportif adalah upaya untuk mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat agar seseorang dapat meminimalkan kesulitan perkembangan psikis.

Kesehatan mental penting untuk dikembangkan, tetapi tidak setiap orang dapat mencapainya dengan mudah. Ada orang yang memiliki kondisi mental yang baik dan harus menghindari gangguan mental, tetapi beberapa di antaranya mengalami kendala dalam perkembangan mentalnya. Jadi, cara kesehatan mental digunakan untuk preventif, amelioratif, dan preservatif berbeda untuk setiap orang.

4. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kesehatan Mental Masyarakat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al. 2024, terdapat banyak gangguan mental di masyarakat. Namun, hingga saat ini, orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan dan perlakuan yang salah. Stigma menyebabkan hal ini, yang membutuhkan intervensi dari perspektif kesehatan masyarakat. Program pencegahan menurunkan risiko gangguan kesehatan mental dan lebih murah. Pemerintah harus mengambil tindakan penanggulangan yang menyeluruh, dimulai dengan peraturan kebijakan yang mendukung pendanaan, akses ke pelayanan kesehatan mental, dan mendukung strategi berbasis komunitas (Nur Haryanti et al., 2024).

Menurut penelitian Nurmala tahun 2024, kesadaran akan kesehatan mental adalah kunci untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan trauma. Selain itu,

perhatian utama telah diberikan pada regulasi lokal yang ideal, pengembangan program kesehatan mental yang komprehensif, dan peran aktif agama dan keluarga dalam mendukung kesehatan mental. Hak asasi manusia harus melindungi kesehatan mental, dan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, agama, masyarakat, dan sektor lainnya sangat penting untuk kesuksesan (Ariadi, 2019).

Sulis Winurini, 2023, mengatakan bahwa meskipun upaya yang telah dilakukan untuk menangani masalah kesehatan mental telah dilakukan, upaya tersebut masih kurang efektif karena berbagai masalah yang terkait. Beberapa masalah ini termasuk tenaga kerja yang terbatas, tidak merata, kualitas layanan kesehatan mental yang buruk, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental. Sangat penting untuk mengubah sistem kesehatan mental untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memasukkan penanganan kesehatan mental ke dalam sistem kesehatan secara keseluruhan (Winurini, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengurangi masalah kesehatan mental, seperti mempekerjakan psikolog di puskesmas dan membuat aplikasi seluler "Sehat Jiwa" yang memudahkan orang untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan mental. Di era modern penanggulangannya di Indonesia, masyarakat dan komunitas juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan layanan kesehatan mental (IAurel Sulthon Hakim; Aji Mulyana; Mia Amalia, 2024).

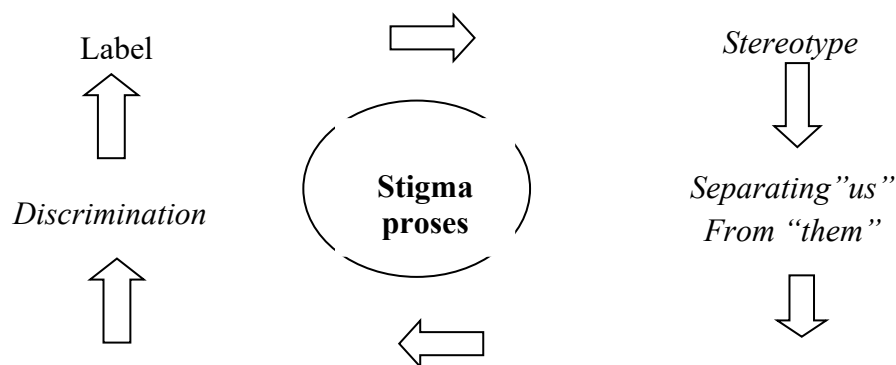
Menurut penelitian Rila Kusumaningsih tahun 2023, peran pemerintah dalam mengatasi gangguan kesehatan mental meliputi penerapan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan; penyediaan sistem, prasarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan jiwa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang terlatih; dan mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan (Kusumaningsih, 2023).

Khoirunnisa, 2023, menyatakan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Layanan Kesehatan Universal memerlukan diskusi lebih lanjut tentang masalah kesehatan mental saat ini. "Sehat Jiwa" adalah aplikasi digital kesehatan mental yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, kemajuan dalam informasi kesehatan mental di Indonesia telah terjadi, meskipun lambat. Oleh karena itu, untuk membuat kebijakan yang efektif untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan jiwa di tingkat pelayanan kesehatan primer dan sekunder, diperlukan data yang cukup (Ghefira et al., 2023).

D. Strategi Pengurangan Stigma

1. Pengertian stigma

Stigma merupakan respons negatif terhadap perbedaan manusia, ini terlihat tanda yang jelas atau perbedaan perilaku. Orang yang dianggap berbeda sering diberi label, misalnya sebagai penderita kusta atau kasus mental. Masyarakat cenderung memiliki stereotip dengan label, pandangan tertentu tentang orang tersebut seperti (sangat menular, mengutuk, berdosa, ditolak oleh masyarakat dalam kasus kusta atau berbahaya, tidak dapat diandalkan dan tidak mampu mengambil keputusan dalam kasus penyakit mental). Ketika stereotip seperti melekat label, orang cenderung tidak lagi melihat orang yang sebenarnya, tetapi hanya stereotip. Orang-orang kemudian cenderung memisahkan diri dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Di ujung lain dari spektrum adalah perilaku negatif yang jelas, sering disebut diskriminasi (Van Brakel et al., 2011). Dibawah ini merupakan gambar proses stigma menurut *The International Federation of Anti-Leprosy Associations* (ILEP).



Gambar 5.2 Proses stigma(Van Brakel et al., 2011)

Labeling merupakan suatu sumber stigmatisasi dari suatu keadaan yang jelas dan nyata terhadap penggunaan label atau nama suatu penyakit yang dipersepsikan secara salah. Seseorang yang didiagnosa menderita kusta merupakan suatu istilah yang penuh dengan persepsi dan berkenaan terhadap suatu perumpamaan sehingga dipersepsikan oleh penderita sebagai kondisi yang cacat bagi dirinya (White, 2008). Stigma sebagai suatu atribut yang sangat mendiskreditkan dan seseorang yang mendapatkan stigma adalah seseorang yang tidak diterima dan tidak mendapatkan penghormatan, hak dan penerimaan dari komunitasnya, atau seseorang yang tidak diterima secara sosial (Wong, 2004).

2. Jenis stigma

a. *Perceived atau felt stigma*

Ketakutan membayangkan sikap nyata dari masyarakat dan diskriminasi yang mungkin timbul dari atribut tertentu yang tidak diinginkan, penyakit, atau asosiasi dengan kelompok tertentu (Hagens T, 2007).

b. *Enacted stigma*

Pengalaman nyata dari diskriminasi, berarti tindakan yang tidak adil dari orang di masyarakat terhadap orang yang terkena kondisi tertentu. Contohnya termasuk penolakan oleh keluarga/masyarakat, pembatasan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan hilangnya pekerjaan karena kusta.(Hagens T, 2007) Stigma yang ditandai dengan suatu keadaan diskriminasi sosial yang nyata atau perilaku negatif (Susanto T, Sahar J, 2013).

3. Penyebab stigma

a. Takut

Ketakutan adalah penyebab umum. Takut penyakit yang menular seperti kusta atau HIV/AIDS. Dalam kasus kusta, takut konsekuensi fisik dari kusta, dalam kasus HIV/AIDS, takut mati. Yang terakhir takut konsekuensi sosial dari pengungkapan kondisi mereka.(van Brakel et al., 2011) Ketakutan penularan jelas salah satu penyebab dilaporkan utama keprihatinan bagi orang-orang dalam sebuah komunitas. Ketakutan ini ditingkatkan oleh tanda-tanda yang membuat orang ingin menjaga jarak aman dan terutama berhati-hati bahwa anak-anak mereka dianggap paling rentan akan tertular (Sermittirong, 2014).

b. Tidak menarik

Beberapa kondisi bisa menyebabkan orang dianggap sebagai tidak menarik, khususnya dalam budaya di mana keindahan lahiriah sangat dihargai. Dalam hal ini, orang-orang dengan gangguan kelihatan di wajah mereka, seperti alis hilang atau hidung runtuh, seperti dapat terjadi pada kasus lanjutan kusta, ditolak hanya karena cara mereka melihat (van Brakel et al., 2011). Klien kusta merupakan bagian dari kelompok dengan kelainan bentuk fisik sehingga ada kelainan bentuk yang kelihatan (Susanto T, Sahar J, 2013).

c. Kegelisahan

Kondisi sangat terlihat dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana harus bersikap dihadapan orang dengan kondisinya dan karena itu memilih untuk menghindari orang (Van Brakel et al., 2011).

d. Asosiasi

Stigma dikenal sebagai stigma simbolik. Dapat terjadi ketika kondisi kesehatan dikaitkan dengan suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan (van

Brakel et al., 2011). Kusta umumnya dipandang sebagai penyakit karena kemiskinan (Susanto T, Sahar J, 2013).

e. Nilai-nilai, Keyakinan dan Agama

Menurut Gussow dan Tracy, stigma berasal dari keyakinan agama yang menganggap penyakit ini sebagai hukuman atas dosa. Keterlibatan Kristen misionaris dalam pengobatan penderita kusta, yang menyebabkan persepsi penyakit sehingga mengerikan hanya hamba Allah yang mampu merawat mereka yang terkena dampak itu. Kusta telah ditafsirkan sebagai hukuman Allah dari dosa (Sermittirong, 2014).

Nilai-nilai dan keyakinan memainkan peran yang kuat dalam menciptakan atau mempertahankan stigma. Contohnya adalah keyakinan tentang penyebab kondisi, seperti keyakinan bahwa kusta adalah kutukan illahi yang disebabkan oleh dosa dalam kehidupan sebelumnya atau kusta ini merupakan penyakit keturunan sehingga seluruh keluarga akan terkena stigma (Van Brakel et al., 2011).

f. Kebijakan atau Undang-Undang

Kebijakan tentang bagaimana dan dimana kondisi diperlakukan dapat menyebabkan stigma. Ini adalah biasanya terlihat ketika kondisi diperlakukan di lokasi yang terpisah seperti klinik leprosy atau klinik untuk penyakit menular seksual terpisah dari RSUD. Contoh lain adalah kebijakan imigrasi atau pekerjaan membutuhkan orang-orang dengan kondisi tertentu untuk menyatakan status mereka (Van Brakel et al., 2011).

g. Kurangnya Kerahasiaan

Pengungkapan yang tidak diinginkan dari kondisi seseorang bisa karena cara hasil tes ditangani atau karena pengungkapan disengaja oleh staf kesehatan atau penanganan yang ceroboh dari data rahasia. Hal ini dapat benar-benar tidak diinginkan, seperti pengiriman dari surat pengingat atau kunjungan oleh petugas kesehatan di dalam kendaraan ditandai dengan logo program (Van Brakel et al., 2011).

4. Dampak stigma

Pengaruh stigma psikologis, orang bisa merasa takut atau malu, yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Karena stigma dan diskriminasi diantisipasi, mereka tidak lagi mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Pengucilan sosial atau diskriminasi dapat mengakibatkan beban ekonomi bagi orang yang terkena dampak atau rumah tangga mereka dengan demikian menyebabkan atau memperburuk kemiskinan. Secara keseluruhan, stigma cenderung memiliki dampak negatif pada kualitas hidup orang yang terkena dampak, keluarga, program kesehatan dan masyarakat (Van Brakel et al., 2011).

Yang merupakan dampak stigma yaitu:(Sermrittirong, 2014).

a. Kesehatan mental

Mengingat pola budaya stigma, termasuk pengucilan sosial, banyak orang yang terkena dampak kusta memiliki masalah mental. Stres dan kecemasan dapat terjadi pada tahap awal kusta, sebelum kerusakan dan cacat.

b. Status ekonomi

Dalam hal status ekonomi, stigma dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan. Sebuah studi di India menemukan bahwa 16-44 % dari mereka dengan kusta melaporkan penurunan pendapatan mereka karena penyakit. Dalam beberapa kasus akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan.

c. Pernikahan dan pendidikan

Pernikahan pasti terpengaruh oleh stigma. Stigma terkait dengan kusta sering menyebabkan perceraian. Bagi orang yang sudah menikah, yang didiagnosis memiliki penyakit kusta bisa memengaruhi stabilitas pernikahan mereka. Beberapa orang telah ditinggalkan atau bercerai oleh pasangan mereka. Selain itu, anak muda laki-laki dan perempuan mungkin menemukan stigma yang bisa membatasi pendidikan mereka, karena sekolah akan menempatkan keterbatasan pada apa yang bisa mereka lakukan. Sebuah studi di Indonesia seorang siswa SMA laki-laki muda yang telah tertular kusta MB, ia harus meninggalkan sekolah ketika gurunya menemukan bahwa ia menderita penyakit kusta.

d. Ketepatan waktu dan keteraturan pengobatan

Stigma memengaruhi terhadap aspek fisik dari penyakit. Ini dapat memengaruhi penderita dalam proses pencarian perawatan dan pengobatan. Rasa malu yang terkait dengan penyakit dapat mencegah orang mencari pengobatan sampai kecacatan yang signifikan telah terjadi. Individu dengan kusta memiliki stres emosional dan kecemasan, yang dapat mengakibatkan morbidity psikologis dan kejiwaan, serta penurunan kualitas hidup.(WHO, 2013)

5. Strategi Pengurangan Stigma

a. Strategi pengurangan stigma Tuberkulosis (TB) terhadap kesehatan mental (Wahyuni et al., 2024)

Untuk mengurangi stigma tuberkulosis, berbagai sektor masyarakat harus terlibat dalam pendekatan multifaset (Sari et al., 2020; Sukartini et al., 2020). Edukasi publik dan informasi adalah pilar utama dalam mengatasi stigma tuberkulosis. Informasi tentang tuberkulosis dapat disebarkan luas kepada masyarakat melalui kampanye kesadaran, menekankan bahwa tuberkulosis adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati. Kampanye ini dapat

mencakup pesan penting tentang cara TB menyebar, betapa pentingnya deteksi dini, dan betapa mudahnya mendapatkan pengobatan yang efektif, dengan tujuan mengurangi ketakutan dan kesalahpahaman yang sering menjadi sumber stigma.

Media harus terlibat dalam pengurangan stigma TB. Untuk menyebarkan pesan positif dan edukatif tentang TB, media sosial dan media konvensional dapat digunakan (Dwinantoaji & Sumarni, 2020; Fathiya & Sitorus, 2023; Isnainy et al., 2022; Kusumawaty et al., 2020). Media dapat memainkan peran penting dalam mengubah persepsi publik dengan menampilkan cerita-cerita sukses dari pasien tuberkulosis yang telah sembuh dan menunjukkan upaya komunitas untuk memerangi tuberkulosis. Ini membantu menciptakan narasi yang lebih positif tentang penyakit dan orang-orang yang terkena dampaknya. Salah satu komponen penting lainnya dalam mengatasi stigma tuberkulosis adalah dukungan sosial dan psikologis. Program dukungan peer-to-peer, di mana pasien tuberkulosis yang telah sembuh memberikan dukungan dan bimbingan kepada pasien baru, dapat sangat efektif. Program seperti ini tidak hanya memberikan dukungan psikologis, tetapi juga membantu orang berbagi pengetahuan praktis tentang bagaimana menangani penyakit dan sistem kesehatan, meningkatkan rasa solidaritas pasien.

Konseling dan terapi juga penting untuk menangani dampak psikologis yang disebabkan oleh tuberkulosis dan stigma yang terkait dengannya. Layanan ini dapat membantu pasien mengatasi perasaan takut, isolasi, atau depresi yang mungkin mereka alami selama atau setelah pengobatan tuberkulosis. Dengan dukungan psikologis, pasien dapat memperkuat ketahanan mental mereka dan menjalani proses penyembuhan mereka dengan lebih positif. Reformasi kebijakan kesehatan dalam domain kebijakan publik dan advokasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pasien tuberkulosis. Reformasi kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status ekonomi atau sosial, memiliki akses yang sama terhadap pengobatan tuberkulosis.

b. Intervensi Untuk Mengurangi Stigma Pada Penderita Skizofrenia (Ardiyani ID; Muljohardjono, 2019)

Untuk melakukan intervensi untuk mengurangi stigma pada penderita skizofrenia, terlebih dahulu diperlukan evaluasi masalah terkait stigma. Ini juga harus menyelidiki dampak dan efek stigma, siapa yang terlibat, proses pemulihan, dan hasil. Setelah prosedur ini selesai, daftar masalah dan keluhan mengenai konsekuensi stigma akan dikumpulkan. Kemudian, berdasarkan

lokasi masalah, tingkat kesulitan, dan ketersediaan dukungan atau sumber daya, dapat dilakukan pembagian tugas. Semua program memiliki tujuan yang berbeda, bisa sementara atau jangka Panjang, bisa mendapatkan dukungan dari organisasi, pemerintah, atau institusi.

Jenis-jenis Strategi Intervensi dalam mengurangi Stigma

Narrative Enhancement Cognitive Therapy (NECT)

Ini adalah intervensi mandiri berbasis kelompok yang bertujuan untuk mengurangi stigma diri, harga diri, dan identitas diri dengan berpedoman pada manual terstruktur yang terdiri dari psikoedukasi, restrukturisasi kognitif, dan terapi naratif. Setiap sesi berlangsung selama dua puluh menit, dan kelompoknya terdiri dari dua fasilitator dan enam hingga delapan peserta. Hasil studi menunjukkan pengurangan signifikan pada stigma diri, peningkatan harga diri, harapan, dan kualitas hidup (Roe et al., 2014).

Intervensi Komprehensif Berbasis Komunitas

Suatu studi uji coba intervensi komprehensif berbasis komunitas yang berlangsung selama sembilan bulan dengan topik Strategi Menentang Stigma dan Diskriminasi (SASD), psikoedukasi, Pelatihan Kemampuan Sosial (SST), dan Cognitive Behavioral Therapy (CBT).

Coming Out Proud (Pengungkapan)

Pedoman berbasis kelompok manual ini, pertama kali diperkenalkan oleh Corrigan et al. (2013), mengguankan pengungkapan diri sebagai metode utama, hidup secara terbuka, asertif, dan keterampilan komunikasi (Rüsch et al., 2014). Intervensi ini terdiri dari tiga sesi, masing-masing 2 jam, setiap minggu sekali, dengan dua fasilitator dan anggota kelompok sebanyak enam hingga sepuluh orang (Rüsch et al., 2014).

- c. Strategi promosi kesehatan berbasis komunitas dalam mengurangi stigma terkait HIV/AIDS (Yulianti & Hadi, 2025)

Untuk mengurangi stigma, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup edukasi publik berbasis komunitas, pelatihan tenaga kesehatan, dan dukungan sosial yang kuat. Pendidikan yang menyeluruh dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS, memecahkan mitos, dan mendorong penerimaan ODHA. Pelatihan tenaga kesehatan juga dapat membantu mereka memberikan perawatan yang inklusif dan nondiskriminatif. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting untuk membantu ODHA menghadapi stigma, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendorong mereka untuk berobat.

- d. Strategi Mengurangi Stigma Penyakit Kusta di Komunitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) (Wahyu & Sahar, 2020)

KIE meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kusta dengan tujuan mengurangi stigma dan menemukan kasus penularan kusta sebelum terjadi kecacatan (Rao & Press, 2015). Intervensi tersebut dengan menemukan kasus lesi kulit untuk segera didiagnosis mencegah masyarakat melihat kusta dengan cara yang tidak baik. Tenaga kesehatan dididik untuk mendeteksi dan merawat kusta (Wijesinghe & Wijesinghe, 2013).

Rehabilitasi Sosial Ekonomi

Program SER (rehabilitasi ekonomi sosial) adalah pendekatan untuk memperbaiki hubungan antara klien kusta dan masyarakat dengan melibatkan klien secara aktif dan mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan memberikan mereka kekuatan untuk membuat dan mengambil keputusan. Dengan memberikan bantuan terus-menerus, perlindungan, dan kolaborasi yang efektif dengan organisasi lain yang mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi klien kusta, program ini dapat membuka peluang dan dukungan bagi penyandang disabilitas klien kusta (Nirman Bhawan, 2015).

- e. Strategi Penanganan Stigma dan Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS Melalui Community System Strengthening (Agung Akbar et al., 2024)

Pendekatan Community System Strengthening bertujuan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik berbasis komunitas dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam tindakan promotif, preventif, kuratif, dan dukungan rehabilitatif pada ODHA. Intervensi dengan pendekatan Community System Strengthening dalam mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHA yaitu melalui education approach, community involvement, dan continuous conselling.

Education Approach

Tinjauan sistematis terkait dengan intervensi pendidikan mengenai HIV berbasis masyarakat yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan pendidikan, kunjungan rumah, pendampingan, kelompok, peer leader, dan program outreach dapat meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko HIV/AIDS dan memastikan kepatuhan pengobatan pada ODHA (Salam, Haroon, Ahmed, Das, & Bhutta, 2014).

Community Involvement: Driven by Community and Opinion Leaders

Keterlibatan komunitas melalui tokoh-tokoh di masyarakat dibutuhkan sebagai strategi untuk masuk ke dalam komunitas. Kehadiran para tokoh masyarakat dapat membantu petugas melakukan kesehatan sosialisasi, dalam

meluruskan disinformasi, memberikan dukungan pada ODHA, mengurangi, dan menghilangkan stigma sosial dan diskriminasi di Masyarakat (Yang, Janamnuaysook, Boyd, Phanuphak, & Tucker, 2019).

Continuous Conselling

Konseling HIV adalah langkah penting untuk mengakses layanan perawatan HIV sebagai strategi pencegahan HIV karena pengetahuan tentang status HIV dapat mengurangi perilaku seksual berisiko (Ferrand & Kranzer, 2014). Konseling HIV berbasis komunitas telah disarankan untuk meningkatkan akses ke layanan pencegahan, perawatan, dan pengobatan HIV bagi individu yang berisiko (Ferrand & Kranzer, 2014).

E. Permasalahan Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia

Di seluruh dunia, terdapat disparitas yang signifikan antara ketersediaan perawatan dan kebutuhan perawatan. Sekitar 85% orang dengan gangguan mental di negara berkembang tidak mendapat pengobatan. Pengeluaran tahunan untuk kesehatan mental masih rendah, kurang dari US\$ 2 per orang, dan jumlah tenaga kerja kesehatan mental kurang dari 1 per 100.000 orang. Jumlah kasus gangguan jiwa di Indonesia kemungkinan besar akan terus meningkat. Menurut laporan Human Rights Watch Indonesia, penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di Indonesia sangat buruk. Lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial pernah dipasung (Nur Haryanti et al., 2024).

Pelayanan kesehatan jiwa sangat penting untuk meningkatkan pengendalian gangguan jiwa yang semakin meningkat. Namun, kurang dari sepuluh persen orang mendapatkan perawatan profesional, terutama di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah, seperti Indonesia. Ini meningkatkan tingkat gangguan yang dialami. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang istilah gangguan psikologis dapat menyebabkan stigma negatif tentang kondisi tersebut, yang menghambat orang untuk mencari bantuan profesional (Kusumaningsih, 2023).

Tidak ada data yang memadai untuk mendukung perumusan kebijakan kesehatan mental, sama halnya seperti yang terjadi di banyak negara berkembang lainnya. Namun, data yang baik sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan upaya penanganan kesehatan mental pada tingkat pelayanan kesehatan primer dan sekunder (IAurel Sulthon Hakim; Aji Mulyana; Mia Amalia, 2024).

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penanganan kesehatan mental. Beberapa pemerintah daerah telah menetapkan peraturan atau peraturan gubernur tentang kesehatan mental, tetapi yang lain belum melakukan tindakan yang

signifikan untuk menangani masalah kesehatan mental. Jumlah psikiater di Indonesia hanya ada 1.053 orang (kemenkes.go.id, 2021). Sementara psikolog klinis yang aktif di Indonesia per Oktober 2023 berjumlah 2.917 orang (ipkindonesia.or.id, 2023). Dengan demikian, 1 psikiater harus melayani 250.000 penduduk, dan 1 psikolog klinis harus melayani sekitar 90.000 penduduk. Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang mensyaratkan rasio psikiater dan psikolog klinis dengan jumlah penduduk idealnya 1:30.000. Tidak hanya dari sisi jumlah, sebaran tenaga kesehatan mental juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental yang terbatas dan belum merata serta mutu layanan yang belum memadai ikut menjadi catatan. Masih ada provinsi yang belum memiliki RSJ dan belum semua rumah sakit umum (RSU) milik pemerintah bisa menyelenggarakan layanan kesehatan mental. Selain itu, obat kesehatan mental di puskesmas seringkali habis karena kendala distribusi obat dari provinsi ke kabupaten/kota. Sebanyak 52,1% penderita gangguan mental skizofrenia/psikosis tidak rutin minum obat (Direktorat Kesehatan Jiwa, 2022). Anggaran kesehatan mental yang terbatas, yaitu sekitar 1% dari total anggaran kesehatan, menjadi salah satu sumber persoalan. Pemahaman masyarakat terkait layanan kesehatan mental juga masih terbatas. Dengan permasalahan seperti ini, tidak heran sekitar 91% penderita depresi di Indonesia tidak menjalani pengobatan medis (Winurini, 2023).

F. Peningkatan Akses Layanan Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 mencakup target kinerja terkait kesehatan mental karena Kementerian Kesehatan adalah lembaga terkemuka dalam penanganan kesehatan mental. Memasukkan indikator kesehatan mental ke dalam banyak program kesehatan adalah salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Selain itu, penanganan lintas sektor sudah terlihat. Misalnya, Kementerian Sosial telah berpartisipasi dalam program bebas pasung dan perbaikan rumah tinggal untuk orang dengan gangguan jiwa. Muncul dan berkembang, lembaga swadaya masyarakat kesehatan mental meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan mendorong perlindungan terhadap ODGJ dan layanan kesehatan mental yang lebih baik (Winurini, 2023).

UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan pedoman untuk penyelenggaraan kesehatan jiwa yang menyeluruh. UU ini menetapkan dasar pelayanan kesehatan jiwa dan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan ini dengan membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan berjenjang. Selain aspek pelayanan, sumber daya yang ditetapkan untuk penyelenggaraan tersebut meliputi sumber daya manusia, fasilitas

pelayanan, perbekalan, teknologi dan produk teknologi, dan pendanaan. Secara tegas dinyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ akan dipidana (Nur Haryanti et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, mencantumkan prinsip prinsip utama dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa, mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental serta upaya pencegahan gangguan jiwa. Pendekatan preventif menekankan pada identifikasi dini faktor risiko dan intervensi untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa. Pendekatan kuratif berfokus pada pengobatan dan penanganan gangguan jiwa yang sudah muncul, sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan jiwa agar dapat berfungsi kembali dalam Masyarakat (Ariadi, 2019).

Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non diskriminasi (Nur Haryanti et al., 2024). Paradigma gerakan kesehatan mental telah berubah, sekarang berfokus pada cara mencegah gangguan mental dan bagaimana komunitas dapat membantu orang menjalani kehidupan mental mereka sebaik mungkin (Nur Haryanti et al., 2024). Kebijakan penanganan kesehatan mental yang diterapkan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program nasional, beberapa komunitas menunjukkan kepedulian terhadap penanganan kesehatan, seperti: Gerakan berbasis komunitas (misal Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia), ketersediaan psikolog di Puskesmas, kader kesehatan jiwa dan Desa Siaga Sehat Jiwa, pemanfaatan teknologi (misal aplikasi kesehatan jiwa di masyarakat oleh Dirkeswa Kemenkes RI dan Pijar Psikologi) (Nur Haryanti et al., 2024).

Metode pengembangan pelayanan kesehatan mental yang berdasarkan komunitas dan hemat biaya. Untuk menurunkan biaya pencegahan dan menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, peraturan kesehatan mental harus dibuat untuk meningkatkan akses, misalnya dengan memberikan dana yang setara untuk layanan kesehatan fisik atau menetapkan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses di rumah sakit umum dan di pusat perawatan kesehatan primer (Nur Haryanti et al., 2024).

Aplikasi seluler Sehat Jiwa adalah salah satu inovasi yang membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan mental. Masyarakat dapat mengidentifikasi kondisi mereka sendiri dan melakukan pemeriksaan diri ke psikolog atau psikiatri terdekat jika diperlukan. Ide tentang layanan kesehatan mental dapat berkembang seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesempatan. Di era digital saat ini, tidak hanya pemerintah yang melakukannya, tetapi juga komunitas dan masyarakat yang peduli dengan kesehatan mental (Ariadi, 2019).

Sangat penting bahwa organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta bekerja sama. Selain itu, penting untuk mengingat keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas pemerhati kesehatan mental, dan media lokal dan sosial. Untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan masyarakat hingga menyentuh semua lapisan masyarakat, partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan. Upaya ini menunjukkan bahwa semua orang bertanggung jawab untuk menangani kesehatan mental (Winurini, 2023).

Program kesehatan jiwa rancangan kemenkes membantu meningkatkan kesadaran akan kesehatan jiwa, meningkatkan deteksi, pencegahan penyakit mental, dan meningkatkan bagaimana kasus ditangani di tingkat pelayanan primer. Pemerintah juga mengupayakan program imunisasi jiwa yang dikembangkan oleh Direktorat P2MKJN (Fidiansyah, 2019). Kementerian Kesehatan juga membuat aplikasi kesehatan jiwa untuk memberi orang akses ke layanan kesehatan digital (Ghefira et al., 2023).

G. Kesimpulan

Kesehatan mental merupakan bagian penting dari definisi kesehatan, dan memiliki peran yang cukup penting untuk memaksimalkan kesehatan setiap individu. Kesehatan mental mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang memengaruhi kesehatan mental, seperti interaksi sosial, psikologis, unsur biologis, ekonomi, lingkungan, dan perilaku. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya kesehatan mental harus mencakup bidang yang lebih luas daripada kesehatan semata-mata (Nur Haryanti et al., 2024). Pemerintah sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai dan optimal ke layanan kesehatan yang layak (Kusumaningsih, 2023).

Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan (well-being) seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada Masyarakat (Ardiansyah et al., 2023). Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi depresi, gangguan emosi, dan gangguan mental berat di Indonesia berada pada taraf mengkhawatirkan (Winurini, 2023). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penanganan kesehatan mental. Jumlah psikiater di Indonesia hanya ada 1.053 orang (kemenkes.go.id, 2021). Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang mensyaratkan rasio psikiater dan psikolog klinis dengan jumlah penduduk idealnya 1:30.000. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental yang terbatas dan belum merata serta mutu layanan yang belum memadai ikut menjadi catatan. Selain itu, obat kesehatan mental di puskesmas seringkali habis karena kendala distribusi obat dari provinsi ke kabupaten/kota. Anggaran kesehatan mental yang terbatas, yaitu sekitar 1% dari total anggaran kesehatan, menjadi salah satu sumber persoalan. Pemahaman masyarakat terkait layanan kesehatan mental juga masih terbatas (Winurini, 2023).

Metode pengembangan pelayanan kesehatan mental yang berdasarkan komunitas dan hemat biaya. Untuk menurunkan biaya pencegahan dan menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, peraturan kesehatan mental harus dibuat untuk meningkatkan akses, misalnya dengan memberikan dana yang setara untuk layanan kesehatan fisik atau menetapkan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses di rumah sakit umum dan di pusat perawatan kesehatan primer (Nur Haryanti et al., 2024).

H. Referensi

- Agung Akbar, M., Studi, P., Keperawatan, D.-I., Tinggi, S., Al-Ma'arif Baturaja, I. K., Agung, M., Program, A., & Keperawatan, S. D.-I. (2024). Strengthening Strategies to Address Stigma and Discrimination of People with HIV/AIDS through Community System Strengthening. *Indonesian Journal of Health Services*, 1(1), 25–29. <https://ejournal.sciencecentergroup.com/index.php/IJHS/25>
- Ardiansyah, S., Tribakti, I., Yuniike, S., Febriani, I., Saripah, E., Bagus, G., Zakiyah, K., Muji, I. K., Egy, R., Putra, S., Kurnia, H., Narulita, S., Juwariah, T., & Akhriansyah, M. (2023). *Kesehatan Mental*. PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Ardiyani ID; Muljohardjono. (2019). Intervensi untuk mengurangi stigma pada penderita Skizofrenia. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 8(1), 8–13.

- Ariadi, P. (2019). Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.32502/sm.v3i2.1433>
- Fakhriyani, D. V. (2019). *Kesehatan Mental*. Duta Media Publishing. <https://www.researchgate.net/publication/348819060>
- Ghefira, K., Kesehatan, Y., Nurul, J., Kesehatan, A., Shifa, J., Maghfiroh, A., Masyarakat, K., Veteran, U. ", Jakarta, ", Dwi, N., Kesehatan, I., Fakultas, J., Kesehatan, I., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Raya, J., Kecamatan, L., & Kota, L. (2023). Tinjauan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia: Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals dan Universal Health Coverage. *Jurnal Medika Nusantara*, 1(2).
- Hagens T. (2007). *A Comparative Study of Stigma and Discrimination Related to Leprosy and HIV/AIDS*.
- Handayani, E. S. (2022). *Kesehatan Mental Mental Hygiene*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bnjari Banjarmasin.
- IAurel Sulthon Hakim; Aji Mulyana; Mia Amalia. (2024). Peran Pemerintah Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Era Modern. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 04(01), 48–54. <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>
- Kusumaningsih, R. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Mental. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 9–22. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>
- Nur Haryanti, A., Bintang Syah Putra, M., Larasati, N., Nureel Khairunnisa, V., & Dyah Dewi, L. A. (2024). Analisis Kondisi Kesehatan Mental di Indonesia Dan Strategi Penanganannya. *Student Research Journal*, 2, 28–40. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1219>
- Sermittirong, S. (2014). *Stigma and stigma interventions related to leprosy and tuberculosis in Thailand*.
- Susanto T, Sahar J, P. H. (2013). *Perawatan Klien Kusta di Komunitas* (Ismail taufik, Ed.; 1st ed.). TIM.
- Van Brakel, W., Voorend, C., Ebenso, B., Cross, H., & Augustine, V. (2011). Guidelines to reduce stigma. *What Is Health-Related Stigma*, 22.
- van Brakel, W., Voorend, C., Ebenso, B., Cross, H., & Augustine, V. (2011). Guidelines to reduce stigma. *What Is Health-Related Stigma*, 22.
- Wahyu, K., & Sahar, J. (2020). Strategi Mengurangi Stigma Penyakit Kusta di Komunitas. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 9(1), 1–116.
- Wahyuni, S., Setiyawati, D., Kementrian, P. K., & Medan, K. (2024). Strategi pengurangan Stigma TB membuka jalan untuk pembicaraan kesehatan mental. *Jurnal Ilmiah Pannmed*, 19(1), 122–132.

- White, C. (2008). Iatrogenic stigma in outpatient treatment for Hansen's disease (leprosy) in Brazil. *Health Education Research*, 23(1), 25–39. <https://doi.org/10.1093/her/cyl158>
- WHO. (2013). *Leprosy*.
- Winurini, S. (2023). Penanganan Kesehatan Mental di Indonesia. *Bidang Kesra Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, 21–25.
- Wong, M. L. (2004). Designing Programmes to address Stigma in Leprosy: Issues and Challenges. *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 15(2), 3–12.
- Yulianti, D. P., & Hadi, E. N. (2025). Strategi Promosi Kesehatan di Komunitas Terhadap Stigma Penderita HIV/AIDS: Sistematis Review. *Jurnal Ners*, 9(2), 1486–1495. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>

I. Glosarium

AIDS	= Acquired Immune Deficiency Syndrome
CBT	= Cognitive Behavioral Therapy
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ILEP	= <i>International Federation of Anti-Leprosy Associations</i>
ODMK	= Orang Dengan Masalah Kejiwaan
ODHA	= Orang Dengan HIV AIDS
ODGJ	= Orang Dengan Gangguan Jiwa
RSU	= Rumah Sakit Umum
RSJ	= Rumah Sakit Jiwa
SER	= rehabilitasi ekonomi sosial
UU	= Undang Undang
WHO	= World Health Organization

PROFIL PENULIS



Dita Retno Pratiwi, SKM., MPH. Lahir di Mataram 9 Mei 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Universitas Universitas Qamarul Huda Badaruddin Lombok Tengah NTB mengampu mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dan praktek kesehatan masyarakat, epidemiologi, pendidikan dan promosi kesehatan, metodologi penelitian dll. buku ini merupakan buku kedua penulis, sebelumnya menulis buku referensi metodologi penelitian kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dita.retnopratiwi@gmail.com



Dr. Faiza Yuniati, S.Pd, S.Kep, M.KM Lahir di Palembang, 26 Juni 1976. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari tingkat Diploma yaitu Akademi Keperawatan Depkes Palembang tahun 1993 dan lulus tahun 1996. Kemudian tahun 1997 melanjutkan Pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2000. Tahun 2004 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Biostatistik dan Kependudukan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 dengan beasiswa dari LPDP. Pada tahun 2022 mengikuti perkuliahan di Program Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Palembang dan lulus pada tahun 2024.

Pada tahun 1999 sampai 2003 bertugas sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang. Sejak tahun 2003 hingga saat ini bertugas sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.

Sejak tahun 2011 aktif mengikuti berbagai konferensi, seminar dan pelatihan pada *event* Nasional maupun Internasional sebagai oral presenter maupun anggota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel ilmiah, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizayuniati@poltekkespalembang.ac.id

Motto: ""Setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah investasi besar untuk masa depan."

PROFIL PENULIS



Dr. Miftahul Munir, S.KM., M.Kes., DIE., Lahir di Lamongan, 19 April, lulus pendidikan DIII Keperawatan di Akademi Keperawatan Soetomo Surabaya tahun 1994, tahun 1995 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, tahun 1996 menjadi dosen di Akper Depkes kampus Tuban, tahun 1997 lulus seleksi Pegawai Negeri Sipil. Menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga lulus tahun 1998, menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga tahun 2000, dan lulus pendidikan Doktor Ilmu Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2016. Tahun 2002 sampai sekarang bekerja sebagai DPK di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban.

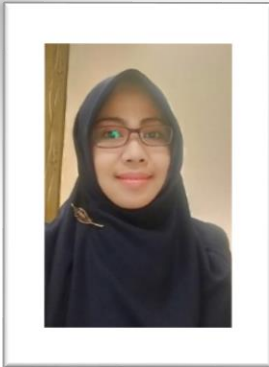
Pengalaman sebagai dosen Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Gerontik sejak tahun 1997. Pengalaman sebagai peneliti pada area kesehatan dan keperawatan di komunitas yang telah dipublikasikan, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional. Saat ini aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengalaman dalam organisasi profesi, aktif sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Tuban, Wakil Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur Bidang Organisasi, sebagai trainer Pelatihan Perkesmas dan Jabatan Fungsional Ferawat Ahli di Badan Diklat DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Dalam pengembangan Keperawatan, aktif sebagai keynote speaker dan invited speaker dalam Seminar ataupun workshop nasional maupun internasional, aktif sebagai narasumber dalam kuliah pakar di beberapa institusi pendidikan keperawatan di Indonesia.

Email : munir.stikesnu@gmail.com



Musliha Mustary, SKM., M.Kes., Penulis lahir di Maros tanggal 03 September 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Studi DIII Kebidanan STIKES Salewanagang Maros. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan InaU dan pendidikan S1 dan S2 pada Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Penulis menjadi dosen tetap sejak 2004. Saat ini penulis melanjutkan pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin.

PROFIL PENULIS



Dr. Cucu Herawati, SKM., M.Kes., lahir di Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia, pada tanggal 24 Desember 1980. Riwayat pendidikan formal penulis melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UHAMKA Jakarta, pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2010. Pendidikan terakhir penulis pada Program Doktor Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2019.

Sejak Februari 2003 penulis memulai karirnya sebagai dosen. Penulis memiliki jabatan akademik dosen Lektor Kepala. Selain rutinitas sebagai dosen, penulis sebagai asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT Kes), asesor Beban Kinerja Dosen (BKD), editor dan reviewer di beberapa jurnal penelitian Nasional terakreditasi, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional bereputasi, dan jurnal pengabdian masyarakat. Sejak tahun 2015 sampai saat ini penulis sebagai tenaga ahli pada berbagai kajian bidang kesehatan dan multidisiplin di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon. Kegiatan penulis pada waktu luang menulis naskah dan memasak. Sejak 2019 penulis memiliki profil google scholar dengan citations berjumlah all 553, h-index 10, dan i10-index 11. Bidang minat area penelitian penulis yaitu Public Health, Health, Medicine, Psiconeuroimunologi, dan Interdisciplinary Research. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: cucueherawatie@gmail.com.

Bunga Rampai: Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi merupakan kumpulan tulisan yang membahas isu-isu penting dan aktual dalam dunia kesehatan masyarakat, dengan pendekatan berbasis epidemiologi dan analisis kebijakan kesehatan. Buku ini dirancang sebagai referensi ilmiah sekaligus panduan praktis bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, akademisi, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami dinamika serta tantangan di bidang kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Lima bab dalam buku ini menghadirkan tema-tema strategis yang saling berkaitan. Pembahasan diawali dengan topik *Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko*, yang menekankan pentingnya perubahan gaya hidup dan intervensi dini dalam pencegahan penyakit kronis yang semakin meningkat prevalensinya. Dilanjutkan dengan bahasan *Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular*, yang mengulas efektivitas program vaksinasi nasional serta dampaknya dalam mengendalikan penyebaran penyakit infeksi.

Bab ketiga mengangkat *Analisis Sistem Kesehatan di Indonesia*, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan kesehatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Bab keempat membahas strategi penurunan angka kematian ibu dan anak dalam konteks *Kesehatan Ibu dan Anak*, yang merupakan indikator utama kesejahteraan suatu bangsa. Terakhir, bab kelima mengupas isu *Kesehatan Mental Masyarakat*, mulai dari upaya pengurangan stigma hingga pentingnya perluasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan manusiawi.

Dengan gaya bahasa yang jelas dan sistematis, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga pendekatan praktis dan refleksi kritis terhadap realitas sistem kesehatan saat ini. Buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang kesehatan masyarakat serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.



Bunga Rampai: Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi merupakan kumpulan tulisan yang membahas isu-isu penting dan aktual dalam dunia kesehatan masyarakat, dengan pendekatan berbasis epidemiologi dan analisis kebijakan kesehatan. Buku ini dirancang sebagai referensi ilmiah sekaligus panduan praktis bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, akademisi, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami dinamika serta tantangan di bidang kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Lima bab dalam buku ini menghadirkan tema-tema strategis yang saling berkaitan. Pembahasan diawali dengan topik Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko, yang menekankan pentingnya perubahan gaya hidup dan intervensi dini dalam pencegahan penyakit kronis yang semakin meningkat prevalensinya. Dilanjutkan dengan bahasan Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular, yang mengulas efektivitas program vaksinasi nasional serta dampaknya dalam mengendalikan penyebaran penyakit infeksi.

Bab ketiga mengangkat Analisis Sistem Kesehatan di Indonesia, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan kesehatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Bab keempat membahas strategi penurunan angka kematian ibu dan anak dalam konteks Kesehatan Ibu dan Anak, yang merupakan indikator utama kesejahteraan suatu bangsa. Terakhir, bab kelima mengupas isu Kesehatan Mental Masyarakat, mulai dari upaya pengurangan stigma hingga pentingnya perluasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan manusiawi.

Dengan gaya bahasa yang jelas dan sistematis, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga pendekatan praktis dan refleksi kritis terhadap realitas sistem kesehatan saat ini. Buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang kesehatan masyarakat serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-06-0



9

786347

219060